KARYA TULIS ILMIAH

MANAJAMEN ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS PADA BAYI "F" DENGAN IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH SAKIT TK II PROF DR.J.A LATUMETEN AMBON

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya Kebidanan (Amd.Keb)

Oleh:
HESTY SINTIA SEPTORY
B2214016

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
TAHUN
2025

KARYA TULIS ILMIAH

MANAJAMEN ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS PADA BAYI "F" DENGAN IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH SAKIT TK II PROF DR.J.A LATUMETEN AMBON

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya Kebidanan (Amd.Keb)

Oleh:
HESTY SINTIA SEPTORY
B2214016

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
TAHUN
2025

Program Studi Diploma III Kebidanan STIKes Pasapua Ambon

Karya Tulis Ilmiah,

Hesty Sintia Septory

B2214016

Di Bimbing Oleh: Kurniah Hasbi Abdullah Difinubun S.ST., M.Kes

Manajemen Asuhan Kebidanan Neonatus Pada Bayi "F" Dengan Ikterus Nenatorum Fisiologis di Rumah Sakit TK II. Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon

CCXII+80 halaman, 4 Tabel, 6 Lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang: Ikterus neonatorum adalah kondisi kulit dan bagian putih mata bayi yang menguning pada minggu pertama setelah lahir. Kondisi ini terjadi karena penumpukan bilirubin, yaitu zat kuning yang dihasilkan dari pemecahan sel darah merah. Penyebab umum yang mengakibatkan seorang bayi menjadi kuning yaitu untuk fisiologis (normal): Hati bayi yang belum matang belum mampu mengolah bilirubin dengan cepat serta bayi kekurangan nutrisi ASI yang membuat bayi tidak buang air besar dan terjadilah penumpukan bilirubin, sedangkan untuk patologis (tidak normal): Bisa disebabkan oleh infeksi, ketidakcocokan golongan darah ibu dan bayi, atau kelainan enzim/sumsum tulang.
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan kebidanan pada bayi dengan Ikterus Neonatorum melalui pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi yang berfokus pada pemberian foto terapi untuk menurunkan kadar bilirubin agar bayi tidak mengalami kern ikterus serta evaluasi
Hasil: Setelah dilakukan Asuhan Kebidanan pada bayi F selama 3x24 jam didapatkan TTV dalam batas normal, kulit bayi sudah tidak lagi berwarna kuning, dan nutrisi bayi terpenuhi dengan baik
Kesimpulan: Dari studi kasus yaitu 7 langkah varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah telah dilaksanakan dengan melakukan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi terhadap bayi F di Rumah Sakit RK II.Prof dr J.A. Latumeten serta dilakukan pendokumentasian. Dengan demikian, semua temuan dan tindakan telah dilaksanakan dengan baik dengan hasil tidak terjadi kern ikterus dan kulir bayi telah kembali normal
Daftar Pustaka:21 (2020-2023)
Kata Kunci:Neonatus, Ikterus Neonatorum Fisiologis

HALAMAN PENGESAHAN

PANITIA SIDANG KARYA TULIS ILMIAH

STIKES PASAPUA AMBON

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN

Ambon, 06 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Kurniah Hasbi Abdullah Difinubun, S.ST., M.Kes
NUPTK. 4053774675230203

Anggota Penguji I

Siti Nurhidayati, SST., M,Kes
NUPTK. 1222048801

Penguji II

Ervina E.F. Kuhuparuw, S,Tr,Keb., M,Keb
NUPTK. 3241774675230383

HALAMAN PERSETUJUAN

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: "Manajamen Asuhan Kebidanan Neonatus Pada Bayi F Dengan Ikterus Neonatorum Fisiologis Di Rumah Sakit Tk II Prof Dr.J.A Latumeten Ambon" telah disetujui, diperiksa untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengujui Karya Tulis Ilmiah STIKES Pasapua Ambon

Ambon, 06 Oktober 2025

Pembimbing

Kurniah Hasbi Abdullah Difinubun, S.ST., M.Kes

NUPTK. 4053774675230203

Mengetahui

Ketua Prodi Diploma III Kebidanan
STIKes Pasapua Ambon

Wildia Nanlohy, S.ST., M.Kes

NUPTK. 2433768669230722

MOTTO

"Ora Et Labora"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

NAMA	: Hesty Sintia Septory
NIM	: B2214016
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Tutuwaru, 04 Mey 2003
Agama	: Kristesn Protestan
Suku	: Maluku
Anak ke	: 4 dari 6 Bersaudara
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Demianus Septory
b. Ibu	: Adonia Saupia
Alamat	: Pohon Pule

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Kristen Tutuwaru	: Lulusan 2015
SMP NEGERI I LEMOLA	: Lulusan 2018
SMA NEGERI 12 MBD	: Lulusan 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi diploma III Kebidanan dan memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan dengan judul "Manajamen Asuhan Kebidanan Neonatus Pada Bayi F Dengan Ikterus NeonatorumFisiologis Di Rumah Sakit Tk II Prof Dr.J.A Latumeten Ambon" dengan baik.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari teknik penulisan maupun materi, hal ini karna keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan pembuatan Karya Tulis Ilmiah di masa yang akan datang.

Adapun dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan sumbansi pikiran, Kritikan, Masukan, Motivasi, Bimbingan, dan Arahan untuk setiap data-data yang penulis ambil, baik secara tertulis maupun lisan. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. dr. Swastika Santila Rudani Ake. Selaku Ketua Yayasan Bangun Persada Ambon yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan di STIKES Pasapua ambon
2. Dr. Abdul Tahalib, S,Kep.,Ns., M,Kep. Selaku ketua STIKES Pasapua Ambon Yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang baik sehingga proses belajar dan pengembangan di kampus dapat berjalan dengan baik
3. Wildia Nanlohy, S.ST., M.Kes. Selaku ketua Program Studi Diploma III Kebidanan STIKES Pasapua Ambon yang telah memberikan motivasi, dan dukunggan akademik yang sanggat membantu dalam studi penulis

4. Kurniah Hasbi Abdullah Difinubun, S.ST., M.Kes Selaku pembimbing institusi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan masukan kontruksif bagi penulis selama proses penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik
5. Ibu Siti Nurhidayati, SST., M,Kes. Dan Ibu Ervina E.F.Kuhuparuw, S.Tr.Keb., M.Keb, Selaku dosen penguji 1 dan penguji 2 yang telah memberikan kritikan, masukan dan saran yang kontruksif bagi penulis demi penyempurnaan karya tulis ilmiah ini
6. Seluruh staf dan dosen yang sudah memberikan banyak bimbinggan selama penulis menempuh pendidikan di STIKES Pasapua ambon
7. Keluarga bayi F yang sudah membantu penulis dalam memperoleh data-data guna melengkapi Karya Tulis Ilmiah ini
8. Seluruh pihak Rumah Sakit RK II. Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon yang sudah memberikan ijin dan membantu penulis dalam memperoleh data dan mengimplementasikan asuhan kebidanan guna mendukung penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini
9. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Demianus Septory dan Ibu Adonia Saupia. Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas doa, kasih sayang, kerja keras, nasehat, motivasi, dukungan moral dan materil yang tiada henti kepada penulis selama ini
10. Keluarga Terkasih, Bu Jack, Bu Nando, Bu Oland, Bu Igo dan Usi Lis atas doa, motivasi, dukunggan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang yang selalu menjadi penyemanggat penulis dalam menyelesaikan studi
11. Kepada Teman-Teman yang namanya tertera dan juga teman-teman kebidanan Angkatan 2022 (Alfonsina Samadara, vanessa Rumihin, Aknes Rado, Anggi Salmanu, Marsina Malirafin, Welminci Pookey, Sentia Atabuy, dan Sarah Latupeirissa)Yang sudah boleh bekerja sama, saling memberikan dukunggan, masukan serta motivasi selama proses penelitian sampai penyusunan Karya Tulis Imiah

12. Kepada semua pihak yang tak sempat penulis jabarkan namanya satu persatu yang kehadiranya berperan dalam membantu baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini

Akhirnya penulis mengharapkan semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi kita semua.

Ambon, Oktober 2025
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
LEMBARAN PERSETUJUAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 4
C. Tujuan Penulisan 4
D. Manfaat Penulisan 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
A. Tinjauan Umum Tentang Neonatus 6
B. Tinjauan Umum Tentang Ikterus Neonatorum 13
C. Tinjauan Umum Tentang Ikterus Neonatorum Fisiologis 17
D. Teori Manajemen Kebidanan 23
BAB III LAPORAN KASUS **28**
A. Pengkajian 28
B. Interpretasi data 33
C. Antisipasi Masalah Potensial 34

D. Identifikasi Kebutuhan Segera 34
E. Intervensi 35
F. Implementasi 35
G. Evaluasi 37
BAB IV PEMBAHASAN 47
A. Pengkajian 47
B. Interpretasi Data 48
C. Antisipasi Masalah Potensial 50
D. Indentifikasi Kebutuhan Segera 51
E. Intervensi 51
F. Implementasi 52
G. Evaluasi 53
BAB V PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penilaian APGAR Score……... 7

Tabel 3.1 Penilaian APGAR Score Pada Bayi “F”…… 40

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan Laboratorum Bayi “F”……..41

Tabel 3.3 Hasil Observasi Tanda-Tanda Vital Bayi “F”……45

DAFTAR SINGKATAN

AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
ASI	: Air Susu Ibu
BBL	: Bayi Baru Lahir
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
DJJ	: Denyut Janjung Janin
IMT	: Indeks Masa Tubuh
KIE	: Komunikasi Informasi Edukasi
KPD	: Ketuban Pecah Dini
KU	: Keadaan Umum
DM	: Diabetes Melitus
MPASI	: makanan Pendamping ASI
WHO	: Word Healt Organisation
HPHT	: Hari Pertama Haid Terakhir
TFU	: Tinggi Fundus
BAB	: Buang Air Besar
BAK	: Buang Air Kecil
BB	: Berat Badan
LK	: Lingkar Kepala
PB	: Panjang Badan
LILA	: Lingkar Lengan Atas
LP	: Lingkar Perut

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Lembaran Kegaiatan Konsultasi
Lampiran II	Surat Permohonan Pengambilan data Awal dari Sekolah Tinggi Ilmu Lesehatan Pasapua Ambon kepada Kepala Rumah Sakit TK II Prof J.A Latumeten Ambon
Lampiran III	Surat Disposisi dalam Pengambilan data awal di Rumah Sakit TK II Prof J.A Latumeten Ambon dan surat persetujuan penelitian
Lampiran IV	Surat izin permohonan atau rekomendasi penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pasapua Ambon kepada Direktur Rumah Sakit TK II Prof J.A Latumeten Ambon dan surat persetujuan penelitian
Lampiran V	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Rumah Sakit TK II Prof J.A Latumeten Ambon dan surat persetujuan penelitian
Lampiran VI	Foto-Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Rumah Sakit TK II Prof J.A Latumeten Ambon dan surat persetujuan penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kematian bayi (*infant mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukkan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu Negara serta kualitas hidup masyarakat . Kematian neonatus itu sendiri merupakan kematian bayi yang terjadi pada usia 28 hari pertama setelah lahir yang merupakan salah satu faktor penentu kesehatan dan kesejahteraan pada anak. Salah satu faktor yang menjadi dampak kematian pada bayi jika tidak segera ditangani dengan baik yaitu masalah Ikterus Neonatorum (Bayi Kuning) Ardhiyanti, Y. (2021).

Bayi baru lahir yaitu bayi yang melewati tahap kelahiran, yang berumur 0-28 hari yang membutuhkan proses adaptasi dari kehidupan di dalam rahim ke kehidupan di luar rahim. Adaptasi yang dimaksud adalah kardiopulmonel dan adaptasi fisiologis lainnya yang dibutuhkan sebagai pengganti fungsi plasenta pada saat bayi berada di luar rahim. Untuk itu, Penanganan dan perawatan bayi baru lahir/yang kurang baik dapat berakibat terjadinya kelainan dan menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Bijanti Retno,2022.

Salah Satu penyakit yang sering terjadi pada bayi baru lahir yaitu diantaranya Ikterus Neonatorum. Ikterus merupakan penyebab kematian bayi baru lahir. Bayi yang mengalami ikterus neonatus, ditandai dengan warna kuning di kulit, konjungtiva, dan sklera mata karena penumpukan bilirubin bebas yang berlebihan di dalam darah. (Yanti et al., 2021), penyakit kuning ini juga dapat terjadi pada 2-3 hari pertama setelah melahirkan karena bayi kekurangan ASI (Mardianti et al., 2022),

Menurut WHO (2022), ikterus neonatorum adalah keadaan klinis bayi baru lahir yang ditandai dengan kulit dan bagian putih mata *(sklera)* yang berwarna kuning akibat akumulasi bilirubin *(pigmen kuning)* yang berlebihan di dalam darah.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, ikterus neonatorum adalah suatu kondisi klinis pada bayi baru lahir yang ditandai dengan pewarnaan kuning pada kulit dan sklera (bagian putih mata) akibat penumpukan bilirubin tak terkonjugasi yang berlebihan.

Dan juga perlu diketahui bahwa, kadar bilirubin dalam darah untuk usia <24 Jam pertama kelahiran: Kurang dari 5 mg/dL, 1-2 jam 10-12 mg/dL, 2–3 Hari 12-13 mg/dL untuk bayi yang lahir cukup bulan, dan untuk bayi prematur: Kadar normal umumnya lebih rendah, tidak melebihi 10 mg/dL di atas 10 mg/dL dalam 24 jam pertama kelahiran dapat menyebabkan penyakit kuning pada bayi baru lahir. Dan untuk dampak penyakit kuning pada berat badan jika tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan otak *(Kern ikterus)* yang menyebabkan keterbelakangan mental, serebral lumpuh, ketidakmampuan melihat ke atas, tuli, dan berujung pada kematian (Fatma et al.,2021).

Adapun faktor yang mempengaruhi penyakit kuning neonatal antara lain faktor ibu seperti ras, usia kehamilan, komplikasi kehamilan, penggunaan infus oksitosin, kelahiran prematur, aterem, dan cara persalinan. Fa ktor perinatal seperti infeksi neonatal (asfiksia), trauma lahir *(cephalic hematoma)*, kelahiran prematur, hipoglikemia, berat badan lahir rendah, penggunaan obat-obatan seperti streptomisin, kloramfenikol, benzil alkohol, dan sulfisoxazol. Ada juga factor neonatal seperti asupan ASI yang tidak mencukupi dan hipoalbuminemia (Susanti etal., 2022).

Menurut Data *Word Health Organization* (WHO) pada tahun 2022 terdapat 2,4 juta anak mengalami kematian diseluruh dunia. Sebanyak 47% (1,1 juta) dari jumlah kematian tersebut terjadi pada periode neonatus. Kelahiran premature (35%) dan komplikasi inpartum (24%) adalah penyebab utama sedangkan asfiksia (15%) kelainan kongnital (11%) Ikterus Neonatorum (41%). Yang dimana angka kematian

neonatal yang diperkirakan adalah 2,7 per 1.000 kelahiran hidup meningkat dari 2,4 pada tahun sebelumnya yang dimana untuk perkiraanya yaitu bayi yang lahir pada usia 24 minggu atau lebih dan juga pada usia kehamilan prematur (sebelum 37 minggu)

Berdasarkan survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2023 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Pada profil kesehatan tahun 2022 jumlah kematian neonatus sebanyak 18.281 kematian sekitar 75,5% terjadi pada usia 0-7 hari dan 24% terjadi pada usia 8-28 hari (Kemenkes RI 2022), yang dimana kematian neonatus terbanyak di Indonesia disebabkan oleh (37%) asfiksia, (34%) prematus dan berat badan lahir rendah, (12%) sepsis, (7%) hipotermi, dan (5,6%) untuk masalah kognital, dan untuk kejadian ikterus neonatorum merupakan penyebab nomor tiga dengan preverensi sebesar (27%).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, prevalensi ikterus neonatorum pada ditahun 2024 sebanyak 62.434 kasus sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 79.461 kasus. Yang dimana presentasi ikterus neonatorum tertinggi ditahun 2023 terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 25.661, Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 18.416, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 16.701, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 15.725 dan Kabupaten Buru sebanyak 5.534 kasus (Dinkes Provinsi Maluku tahun 2024).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di rumah sakit TK II Prof dr J A Latumeten Ambon, pada tahun 2021 sebanyak 709 jiwa yang lahir dengan jumlah bayi yang mengalami ikterus sebanyak 15 jiwa (21%), angka kelahiran di tahun 2022 sebanyak 950 jiwa dengan bayi yang mengalami ikterus sebanyak 17 jiwa (23%) pada tahun 2023 sebanyak 832 jiwa yang lahir dengan jumlah bayi yang mengalami ikterus sebanyak 20 jiwa (27%), tahun 2024 angka kelahiran bayi berjumlah 886 jiwa dengan jumlah bayi yang mengalami ikterus sebanyak 17 jiwa (23%), dan untuk data di tahun 2025 dari bulan januari-agustus, dengan jumlah angka kelahiran bayi berjumlah 603 jiwa dengan bayi dengan jumlah bayi yang mengalami ikterus yaitu berjumlah 4 jiwa (0,6%).

Berdasarkan data diatas yang menunjukan bahwa masih banyak neonates yang mengalami ikterus neonatorum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Neonatus Pada Bayi F Dengan Ikterus Neonatorum Di Rumah Sakit TK II Prof Dr.,J.A. Latumeten Ambon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan dari latar belakang di atas penulis menyimpulkan untuk mengangkat masalah dengan judul "Bagaimana penerapan manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan ikterus neonatorum di Rumah Sakit Tk II Prof Dr J.A. Latumeten Ambon?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua bagian diantaranya:

1. Tujuan Umum

   Mampu memberikan pelayanan asuhan kebidanan kebidanan Neonatus pada bayi F dengan masalah Ikterus Neonatorum di Rumah Sakit Tk.IIProf. dr.J.A. Latumeten

2. Tujuan Khusus

   a. Mampu mengumpulkan data dasar atau pengkajian asuhan kebidanan neonatus pada bayi F dengan ikterus neonatorum di Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten.
   b. Mampu melakukan interpretasi data diagnosa asuhan kebidanan neonatus pada bayi F dengan ikterus neonatorum di Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten.
   c. Mampu menetapkan diagnosa potensial asuhan kebidanan neonatus pada bayi F dengan ikterus neonatorum di Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten.
   d. Mampu menetapkan tindakan segera asuhan kebidanan neonatus pada bayi F dengan ikterus neonatorum di Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten.
   e. Mampu merencanakan asuhan kebidanan neonatus pada bayi F dengan ikterus neonatorum di Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten.
   f. Mampu melakukan asuhan kebidanan neonatus pada bayi F dengan ikterus neonatorum di Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten.
   g. Mampu melakukan evaluasi tindakan asuhan kebidanan neonatus pada bayi F dengan ikterus neonatorum di Rumah Sakit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Terbagi atas dua yaitu

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai penunjang dalam berbagai penulisan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan penerapan Asuhan Kebidanan Neonatus dengan Ikterus Neonatorum

2. Manfaat Aplikatif

   a. Bagi Penulis

      Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam praktik di lahan serta mendapat gambaran yang nyata dalam melaksanakan Asuhan Kebidanan Neonatus dengan Ikterus Neonatorum

   b. Bagi Institusi Pendidikan

      Dapat menjadi salah satu sumber bagi pembaca untuk menambah Pengetahuan tentang Asuhan Kebidanan Neonatus dengan Ikterus Neonatorum

   c. Bagi Lahan Penelitian

      Sebagai bahan penimbang dalam pelaksanaan Asuhan Kebidanan Neonatus dengan Ikterus Neonatorum

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Neonatus

1. Definisi Neonatus

baru lahir normal adalah bayi yang lahir cukup bulan (usia kehamilan 37-42 minggu) dengan berat badan 2500-4000 gram, dan tidak menunjukkan adanya kelainan atau cacat bawaan. Selain itu, bayi baru lahir normal juga ditandai dengan tangisan yang kuat segera setelah lahir, gerakan aktif, kulit kemerahan, serta kemampuan menghisap ASI dengan baik.

Definisi bayi baru lahir normal menurut WHO adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan aterm (37-42 minggu) dengan berat badan antara 2500 hingga 4000 gram, serta tidak memiliki cacat bawaan yang signifikan. Bayi juga diharapkan segera menangis setelah lahir, bergerak aktif, dan menunjukkan refleks menghisap yang baik.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023, bayi baru lahir (BBL) atau neonatus adalah bayi yang berusia 0-28 hari, sejak dilahirkan hingga usia satu bulan. Masa ini merupakan periode kritis karena bayi mengalami banyak penyesuaian fisiologis dari kehidupan di dalam rahim ke kehidupan di luar rahim.

2. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir Normal

Menurut suryani dkk 2023, Bayi baru lahir memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Bayi baru lahir dikatakan normal jika usia kehamilan aterm antara 37-42 minggu, Berat Badan 2500-4000 gram, panjang badan 48-52 cm, Lingkar dada 30-38 cm, Lingkar kepala 33-35 cm, Lingkar lengan 11-12 cm, Frekuensi DJJ 120-160 x/menit, Pernapasan 40-60-x/menit, Kulit kemerahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup, Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya

telah sempurna, Kuku agak panjang dan lemas, Nilai APGAR 7-10 diantaranya terdiri dari 5 kriteria yang di test untuk mendapatkan skor Apgar yaitu:

Tabel 2.1 APGAR Score pada bayi baru lahir

Kriteria	Poin	Keterangan
A: Appearance/Warna kulit	2 poin = Warna kulit pink pada tubuh dan ekstremitas 1 poin = Warna kulit biru pada ekstremitas, warna kulit pink pada tubuh 0 poin = Warna kulit seluruh tubuh dan ekstremitas biru	
P : Pulse/ Denyut jantung	2 Poin = >100 1 Poin = <100 O Poin = Tidak ada denyut jantung	
G: Grimance/Respons reflex	2 poin = Bayi menangis, batuk atau bersin 1 poin = Bayi meringis atau menangis lemah saat distimulasi 0 poin = Bayi tidak merespons stimulasi	
A: Activity/Otot/keaktifan	2 poin = Bergerak aktif, 1 poin = Sedikit gerakan, 0 poin = Lemah atau tidak ada gerakan	

R: Respiration/Pernapasan	2 poin = Pernapasan baik, teratur, menangis kuat 1 poin = Pernapasan lemah dan tidak teratur 0 poin = Tidak ada napas	
	7-10	Vigrous Baby (Bayi Normal)
	4-6	Asphyksia (Asfiksia Sedang)
	0-3	Asfiksia Berat

Sumber: Maryanti 2022

3. Penilaian Bayi Baru Lahir
   a. Penilaian awal dilakukan pada setiap BBL untuk menentukan apakah tindakan resusitasi harus segera dimulai (Nilai kondisi bayi)
      1) Apakah kehamilan cukup bulan atau tidak (Kehamilan cukup bulan atau aterm adalah kehamilan yang mencapai usia 39 minggu 0 hari sampai 40 minggu 6 hari dimana organ-organ janin sudah matang dan siap untuk berfungsi diluar janin, sebaliknya untuk kehamilan tidak cukup bulan atau preterm adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu dengan janin yang belum cukup matang dan beresiko mengalami masalah kesehatan seperti kesulitan bernapas atau susah untuk dapat mengendalikan suhu tubuh
      2) Apakah air ketuban jernih atau air ketuban berwarna keconium? Untuk air ketuban jernih itu sendiri diartikan sebagai air ketuban yang tidak bercampur dengan rinja pertama janin yang berarti air ketuban berada pada kondisi yang normal, sedangkan untuk air ketuban bercampur meconium menandakan bahwa adanya potensi resiko terjadinya komplikasi pada janin

3) Apakah bayi menangis kuat/bernafas tanpa kesulitan? Pada bayi yang lahir dan langsung menangis kuat dapat diberikan penilaian nilai sesuai dengan APGAR Score yaitu mendapatkan poin 2 begitupun sebaliknya akan diberikan poin 1 dan bahkan 0

b. Apakah tonus otot bayi baik/bayi bergerak aktif ? diartikan sebagai bayi baru lahir yang memiliki otot yang kuat dan sehat serta mampu menunjukan pergerakan yang lincah dan energik

Bila kondisi bayi normal semua berarti bayi tidak memerlukan tindakan resusitasi. Pada bayi ini segera dilakukan Asuhan Bayi Normal. Bila salah satu atau lebih jawaban “tidak”, bayi memerlukan tindakan tindakan resusitasi segera dimulai dengan langkah awal resusitasi.

c. Apgar score

merupakan alat untuk mengkaji kondisi bayi sesaat setelah lahir meliputi 5 variabel pernafasan, frekuensi jantung, warna, tonus otot dan iritabilitas refleks. Apgar dilakukan pada :

a. 1 menit kelahiran yaitu untuk memberi kesempatan pada bayi untuk memulai perubahan
b. Menit ke-5
c. Menit ke-10,penilaian dapat dilakukan lebih sering jika ada nilai yang rendah dan perlu tindakan resusitasi. Penilaian menit ke10 memberikan indikasi morbiditas pada masa mendatang. Nilai yang rendah berhubungan dengan kondisi neurologis.

d. Balard Score

Menurut Rahmawati & Ningsih 2021, a. *Balard Score* merupakan suatu versi sistem *Dubowitz*. Pada prosedur ini penggunaan kriteria neurologis tidak tergantung pada keadaan bayi yang tenang dan beristirahat, sehingga lebih dapat diandalkan selama beberapa jam pertama kehidupan. Penilaian menurut *Ballard* adalah dengan menggabungkan hasil penilaian maturitas *neuromuskuler* dan maturitas fisik, Kriteria pemeriksaan maturitas *neuromuskuler* diberi skor, demikian pula kriteria pemeriksaan maturitas fisik. Jumlah skor pemeriksaan maturitas neuromuskuler dan maturitas fisik digabungkan, kemudian dengan menggunakan tabel nilai kematangan dicarimasa gestasinya

4. Adaptasi Bayi Baru Lahir Terhadap Kehidupan di Luar Uterus

Menurut Sondakh & Jenny 2022 adaptasi bayi baru lahir merupakan proses penyesuaian fungsional neonatus dari kehidupan di dalam rahim ke kehidupan di luar rahim. Beberapa perubahan fisiologi yang terjadi pada bayi baru lahir seperti:

a. Perubahan sistem pernapasan

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi selama 30 detik sesudah kelahiran. Pernapasan ini timbul sebagai akibat aktivitas normal sistem saraf pusat dan saraf tepi yang dibantu oleh beberapa rangsangan lainnya. Frekuensi pernapasan bayi baru lahir berkisar 30-60 kali/menit.

b. Perubahan sistem kardiovaskuler

Dengan berkembangnya paru-paru, pada alveoli akan terjadi peningkatan tekanan oksigen. Sebaliknya, tekanan karbon dioksida akan mengalami

penurunan. Hal ini mengakibatkan penurunan resistansi pembuluh darah dari *arteri pulmonalis* mengalir ke paru-paru dan *ductus arteriosus* tertutup.

c. Perubahan sistem termoregulasi dan metabolik

Sesaat setelah lahir, bila bayi dibiarkan dalam suhu ruangan 250C, maka bayi akan kehilangan panas melalui evaporasi, konveksi, konduksi, dan radiasi. Suhu lingkungan yang dingin akan menyebabkan bayi terkena hipotermi dan trauma dingin.

d. Perubahan system saraf *(Neurologis)*

Sistem neurologis bayi secara anatomi atau fisiologis belum berkembang sempurna. Bayi baru lahir menunjukkan gerakangerakan tidak terkoordinasi, pengaturan suhu yang labil, control otot yang buruk, mudah terkejut, dan tremor pada ekstremitas.

e. Perubahan Saluran Pencernaan *(gastrointestinal)*

Kadar gula darah tali pusat 65 mg/100 mL akan menurun menjadi 50 mg/100 mL dalam waktu dua jam sesudah lahir, energy tambahan yang dibutuhkan neonatus pada jam-jam pertama sesudah lahir diambil dari hasil metabolism asam lemak sehingga kadar gula akan mencapai 120 mg/100mL.

f. Perubahan ginjal

Sebagian besar bayi berkemih dalam 24 jam pertama setelah lahir dan 2-6 kali sehari pada 1-2 hari pertama, setelah itu bayi akan berkemih 5-20 kali dalam 24 jam.

g. Perubahan hati

Dan selama periode neonatus, hati memproduksi zat yang essensial untuk pembekuan darah. Hati juga mengontrol jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang bersirkulasi, pigmen berasal dari hemoglobin dan dilepaskan bersama sel-sel darah merah.

h. Perubahan imun

Bayi baru lahir tidak dapat membatasi organisme penyerang pintu masuk. Imaturnitas jumlah sistem pelindung secara signifikan meningkatkan resiko infeksi pada bayi baru lahir.

i. Pemeriksaan Fisik Pada Bayi baru Lahir

Pem eriksaan fisik BBL bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin apakah terdapat kelainan pada bayi. Risiko terbesar kematian BBL terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Pengkajian fisik pada bayi baru lahir dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengkajian segera. Setelah lahir, tujuan pengkajian ini adalah mengkaji adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus, yaitu dengan melakukan penilaian APGAR Penilaian ini meliputi (denyut jantung), (warna kulit), (refleks atau respons terhadap rangsang).(usaha bernapas), (tonus otot), dan Tahap kedua adalah pengkajian keadaan fisik bayi baru lahir. Pengkajian ini dilakukan untuk memastikan bayi dalam keadaan normal a tau tidak mengalami penyimpangan (Dr.Lyndon Saputra, 2022).

5. Masalah Yang Sering Terjadi Pada Bayi baru Lahir

Menurut Sondakh & Jenny 2022, masalah-masalah yang sering terjadi pada bayi baru lahir diantaranya:

a. Masalah Umum & Non-Serius

1) Penyakit Kuning (Jaundice): Kulit bayi menguning, termasuk bagian wajah dan mata, karena kadar bilirubin yang tinggi.
2) Kolik: Bayi menangis terus-menerus tanpa alasan jelas, terutama di malam hari, meskipun tidak ada masalah medis yang serius.
3) Gumoh: Muntah kecil-kecil setelah minum susu, biasanya karena menelan terlalu banyak udara saat menyusui.
4) Masalah Kulit: Ruam popok akibat popok yang terlalu lembab atau alergi, serta kerak kulit kepala.
5) Masalah Pencernaan: Konstipasi (sembelit) atau diare, karena sistem pencernaan bayi masih berkembang.

b. Masalah yang Memerlukan Perhatian Lebih

1) Gangguan Pernapasan: Bayi prematur berisiko mengalami masalah paru-paru karena belum matangnya organ tersebut.
2) Infeksi Berat (Sepsis): Infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh bayi dan dapat mengancam jiwa.
3) Gula Darah Rendah (Hipoglikemia): Kadar gula darah yang terlalu rendah pada bayi, terutama bayi prematur atau yang lahir dengan berat badan rendah.
4) Masalah Tali Pusat: Infeksi atau masalah lain pada tali pusat yang belum terlep

c. Kondisi yang Lebih Serius

1) Cacat Lahir: Kelainan bawaan yang mempengaruhi organ tubuh dan memerlukan perawatan khusus atau pembedahan.
2) Meningitis: Peradangan selaput otak akibat infeksi, bisa menyebabkan demam tinggi, leher kaku, kejang, dan perlu segera ditangani dokter.

d. Yang Perlu Dilakukan Orang Tua

1) Percaya pada Insting: Jika Anda khawatir dengan kondisi bayi, jangan ragu untuk segera menghubungi dokter atau penyedia layanan kesehatan.
2) Pencegahan: Jaga kebersihan bayi, ganti popok secara teratur, dan berikan ASI atau susu formula sesuai anjuran.
3) Perawatan Tali Pusat: Bersihkan tali pusat dengan kapas steril dan jaga agar tetap kering untuk mencegah infeksi.

6. Kadar Bilirubin Bayi Cukup Bulan

American Pregnancy Association (APA) 2022

Usia bayi Setelah lahir	**Kadar Bilirubin Normal**
< 24 jam	< 5
24-48 Jam	< 10-15
49-72 Jam	< 12-18
> 72 jam	< 15-20

B. Tinjauan Umum Tentang Ikterus Neonatorum

1. Definisi Ikterus Neonatorum

Ikterus neonatorum adalah kondisi menguningnya kulit dan mata bayi baru lahir akibat penumpukan bilirubin, biasanya terjadi dalam minggu pertama setelah bayi lahir. Yang biasanya dapat bersifat fisiologis patologis.

Menurut Nelson Textbook of Pediatrics 2022 ikterus neonatorum adalah: Kondisi yang ditandai dengan pewarnaan kuning pada kulit, sklera, dan mukosa akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah pada bayi baru lahir. Biasanya muncul dalam minggu pertama kehidupan.

Ilmu Kebidanan Ikterus neonatorum adalah kondisi klinis pada bayi baru lahir yang ditandai dengan ikterus (kulit dan sklera tampak kuning) yang biasanya timbul pada hari ke-2 sampai ke-7 setelah lahir, dan disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah (Prawirohardjo,s 2022)

Menurut WHO 2022: Ikterus neonatal adalah perubahan warna kekuningan pada kulit dan sklera bayi baru lahir yang disebabkan oleh akumulasi bilirubin dalam darah.

Menurut Kemenkes RI, ikterus adalah suatu keadaan klinis pada bayi yang ditandai dengan pewarnaan kuning pada kulit dan sklera (bagian putih mata)

2. Etiologi Ikterus Neonatus

Faktor-faktor yang memengaruhi ikterus neonatus antara lain sebagai berikut (Susanti et al., 2022).

a. Faktor ibu seperti ras, usia kehamilan, komplikasi kehamilan, penggunaan infus oksitosin, kelahiran prematur, aterem, dan cara persalinan.

b. Faktor perinatal seperti asfiksia (infeksi neonatal) dan trauma lahir *(cephalohematoma).*
c. Faktor neonatal seperti hipoglikemia, prematuritas, berat badan lahir rendah, penggunaan obat seperti streptomisin, kloramfenikol, benzyl alkohol, sulfisoksazol juga asupan ASI yang tidak mencukupi dan *hipoalbuminemia.*
d. Penyebab prehepatik menghasilkan kelebihan bilirubin akibat peningkatan proses hemolitik. Kondisi ini dapat terjadi karena inkompatibilitas rhesus, defisiensi enzim ABO, G6PD, dan sepsis.
e. Penyebab yang berhubungan dengan hati, seperti ketidakmatangan hati pada bayi prematur, dapat menyebabkan kurangnya substrat pengikatan bilirubin, gangguan proses penyerapan, dan kurangnya enzim glukoroniltransferase.

3. Klasifikasi ikterus Neonatorum

Ikterus Neonatorum terbagi menjadi dua bagian diantaranya Ikterus Fisiologis dan Ikterus Patologis

a. Ikterus fisiologis

1) Definisi

Menurut Saleha 2021, Ikterus Fisiologi adalah: Kondisi ikterus yang umum, ringan, normal dan hanya bersifat sementara pada bayi baru lahir yang muncul setelah 24 jam dan hilang <14 hari (Kurang dari 14 hari)

2) Faktor penyebab

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya ikterus neonatorum fisiolog is yaitu kematangan organ hati bayi yang belum sempurna untuk memproses dan mengeluarkan bilirubin , kurangnya asupan nutrisi/cairan ASI sehingga kurangnya

pengeluaran meconium (feses pertama bayi) karena kurangnya asupan ASI sehingga bilirubin diserap kembali kedalam darah.

b. Ikterus Patologis

1) Definisi

Menurut Yongky dkk, 2021, Ikterus patologis merupakan: Kondisi ikterus yang lebih serius dan memerlukan penanganan medis karena adanya penyebab yang mendasari. Waktu Muncul kurang dari 24 jam setelah lahir atau bertahan lebih dari 14 hari.

2) Faktor Penyebab Ikterus Neonatorum patologis

Beberapa faktor yang menjadi penyebab ikterus neonatorum patologis diantara yaitu: penghancuran sel darah merah yang berlebihan (seperti akibat inkompatibilitas golongan darah atau Rh, kelainan genetik), masalah pada organ hati (misalnya infeksi atau penyakit hati bawaan), peningkatan bilirubin dari sumber lain (seperti gangguan pencernaan atau sirkulasi enterohepatik), ketidakmatangan fungsi hati bayi yang memperparah penumpukan bilirubin. Dan juga faktor ibu seperti infeksi selama kehamilan, penggunaan obat-obatan tertentu, atau persalinan prematur.

4. Komplikasi Ikterus Neonatus

Komplikasi pada ikterus neonatus antara lain (Mustofa et al., 2022):

a) *Kern Icterus* atau ensefalopati bilirubin.

Merupakan cedera otak akibat pengendapan bilirubin tidak langsung di otak, terutama di striatum, talamus, nukleus subtalamus, hipokampus, dan nukleus dasar ventrikel.

b) Asfiksia

Asfiksia merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh menurunnya kadar oksigen dalam tubuh. Tersedak biasanya disebabkan oleh gangguan pernafasan.

c) Hipotermia

Hipotermia adalah suatu kondisi dimana suhu tubuh tiba-tiba turun di bawah 35 ° C. Akibatnya, jantung dan organ vital lainnya berhenti berfungsi. Jika tidak segera ditangani, hipotermia dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan sistem pernapasan, dan bahkan kematian.

d) Hipoglikemia

Hipoglikemia adalah suatu kondisi dimana kadar gula darah berada di bawah normal. Selain sering menyerang penderita diabetes, berbagai penyakit lain dan obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan kondisi ini.

5. Derajat Ikterus (Metode Kramer)

1) Derajat 1: Kuning pada bagian kepala dan leher. Perkiraan kadar bilirubin: \(4-8\) mg/dL. Derajat
2) Kuning dari kepala hingga badan atas (di atas umbilikus). Perkiraan kadar bilirubin: \(5-12\) mg/dL. Derajat
3) Kuning dari kepala hingga badan bawah (di bawah umbilikus dan paha). Perkiraan kadar bilirubin: \(8-16\) mg/dL. Derajat
4) Kuning dari kepala hingga tangan dan tungkai bawah (di atas lutut). Perkiraan kadar bilirubin: \(11-18\) mg/dL. Derajat

5) Kuning di seluruh tubuh, termasuk telapak tangan dan telapak kaki. Perkiraan kadar bilirubin: \(>15\) mg/dL.

Dari pembahasan derajat ikterus diatas dan disesuaikan dengan kasus yang diteliti maka kasus ikterus neonatorum fisiologisnya terdapat pada derajat nomor 3 yaitu Kuning dari kepala hingga badan bawah (di bawah umbilikus dan paha). Perkiraan kadar bilirubin: \(8-16\) mg/dL karena sesuai dengan hasil laboratorium pemeriksaan bilirubin pada bayi F yaitu 13 mg/dL.

2. Penatalaksanaan Medis Dan kewenangan Bidan

a. Penanganan Sendiri di Rumah

6) Anjurkan ibu untuk memberikan ASI yang cukup yaitu 8-12 kali sehari.

7) Anjurkan ibu untuk menjemur bayinya karena matahari akan membantu memecahkan bilirubin sehingga lebih mudah diproses di hati. Caranya:

a) Tempatkan bayi dekat jendelah yang terbuka untuk mendapatkan matahari pukul 7-8 pagi.

b) Atur posisi bayi agar wajahnya tidak langsung menghap matahari

c) Lakukan penyinaran 30 menit yaitu 15 menit terlentang dan 15 menit tengkurap

d) Usahakan sinar matahari langsung mengenai kulit bayi oleh karenanya sebaiknya bayi telanjang tetapi jaga agar bayi tidak kedinginan (Amellia,2022)

b. Terapi Medis

Terapi medis dapat dilakukan dengan terapi sinar (phototherapy).

1) Tempatkan bayi baru lahir di dalam inkubator dengan bank cahaya fototerapi kira-kira 12-30 inci dari bayi baru lahir.
2) Lindungi mata bayi baru lahir dengan menggunakan penutup mata yang lembut. Berhati-hatilah dalam penempatan penutup mata agar tidak menyumbat lubang hidung. Lepaskan penutup mata sesering mungkin untuk memeriksa adanya rabas mata akibat reaksi terhadap profilaksis rutin atau infeksi (konjung tiva) akibat pajanan mikroorganisme dijalan lahir.
3) Saat diterapi, bayi tidak mengenakan pakaian kecuali popok dan seringlah ganti posisinya.
4) Pantau kondisi kulit dan ganti popok lebih sering.
5) pantau asupan dan keluaran serta amati adanya tanda-tanda dehidrasi.
6) Pantau suhu dan pertahankan lingkungan ternal yang netral.
7) Pantau intensitas cahaya dengan bilimeter.
8) Pindahkan bayi dari terapi untuk menggendong dan memberi makan, kecuali jika dikontraindikasikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Ikterus Neonatorum Fisiologis

1. Definisi Ikterus Neonatorum Fisiologis

Ikterus Fisiologis adalah: Kondisi ikterus yang umum, ringan, normal dan hanya bersifat sementara pada bayi baru lahir yang muncul setelah 24 jam dan hilang <14 hari (Kurang dari 14 hari) yang dimana yang menjadi faktor terjadinya ikterus fisiologi itu sendiri diantaranya hipoksia, kurangnya asupan ASI, penyakit membrane hialin (HMD), hipoglikemia, asidosis, hipotermia dan

hipoprotemia dan kematangan organ hati bayi yang belum sempurna untuk memproses dan mengeluarkan bilirubin (Bijanti Retno,2022)

2. Klasifikasi Ikterus Neonatorum Fisiologi

Klasifikasi ikterus fisiologi pada neonatus ditentukan berdasarkan kriteria klinis dan laboratorium, yang dimana gejalanya muncul pada hari kedua atau ketiga setelah bayi lahir dan menghilang sebelum bayi berusia 2 minggu serta tidak melewati kadar bilirubin tertentu (Oswari Hanifah, 2021)

3. Karakteristik Ikterus Fisiologis

Menurut (Magdalena C 2020), Ikterus Fisiologis mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. Timbul pada hari ke 2-3 dan hilang pada umur 4-5 hari. Kadar bilirubin indirek (larut dalam lemak) tidak melewati 12 mg/dl pada neonatus cukup bulan dan 15 mg/dL pada kurang bulan.
b. Kecepatan peningkatan kadar bilirubin tidak melebihi 5 mg/dL per hari.
c. Kadar bilirubin direk (larut dalam air) kurang dari 1mg/dL.
d. Gejala ikterus akan hilang pada sepuluh hari pertama kehidupan.
e. Tidak terbukti mempunyai hubungan dengan keadaan patologis tertentu

4. Etiologi Ikterus Fisiologis

Etiologi peningkatan bilirubin umum terjadi pada setiap bayi baru lahir karena hemolisis yang disebabkan oleh jumlah sel darah merah lebih banyak dan berumur lebih pendek, Fungsi hepar yang belum sempurna sehingga terjadi penurunan bilirubin oleh hepatosit dan konjugasi, kurangnya asupan nutrisi/cairan ASI sehingga kurangnya pengeluaran meconium (feses pertama

bayi) sehingga bilirubin diserap kembali kedalam darah dan terjadi penumpukan bilirubin dan juga disfungsi hati pada bayi baru lahir sehingga organ hatipada bayi tidak dapat berfungsi maksimal dalam melarutkan bilirubin ke dalam air yang selanjutkan disalurkan ke empedu dan diekskresikanke dalam usus menjadi urobilinogen.

Hal tersebut meyebabkan kadar bilirubin meningkat dalam plasma sehingga terjadi ikterus pada bayi baru lahir (Anggraini, 2022). Etiologi ikterus pada bayi baru lahir dapa berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut :

a. Produksi yang berlebihan, lebih daripada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya, misalnya hemolisi yang meningkat pada inkompatibilitas, perdarahan tertutup dan sepsis.
b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukorinil transferase (*criggler najjar syndrome*). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperanan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel heapar
c. Gangguan dalam transportasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut ke hepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya salisilat, sulfatfurazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak.

d. Gangguan dalam sekresi, gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar, biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain
e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat mengakibatkan hiperbilirubinemia tidak terkonjugasi akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulais enterahepatik.
f. Ikterus akibat air susu ibu (ASI) merupakan hiperbilirubinemia tidak terkonjugasi yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 5-6). Dapat dibedakan dari penyebab lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini untuk membedakan ikterus pada bayi yang disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagian bahan yang terkandung dalam ASI (beta glucoronidase) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak sehingga bilirubin indirek akan meningkat dan kemudian akan diresorbsi oleh usus. Bayi yang mendapat ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan pada beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian (Sembiring Br J,2021)

5. Patofisologi Ikterus Fisiologi

a. Ikterus fisiologi

Sel-sel darah merah yang telah tua dan rusak akan dipecah menjadi bilirubin, yang oleh hati akan dimetabolisme dan dibuang melalui feses. Di dalam usus juga terdapat banyak bakteri yang mampu mengubah bilirubin sehingga mudah dikeluarkan oleh feses. Hal ini terjadi secara normal pada orang dewasa. Pada bayi baru lahir, jumlah bakteri metabolisme bilirubin ini masih belum mencukupi sehingga ditemukan bilirubin yang masih beredar dalam tubuh tidak dibuang bersama feses. Begitu pula dalam usus bayi terdapat enzim glukoriniltransferase yang mampu mengubah bilirubin dan menyerap kembali bilirubin kedalam darah sehingga makin memperparah akumulasi bilirubin dalam badannya. Akibatnya pigmen tersebut akan disimpan dibawah kulit, sehingga kulit bayi menjadi kuning. Biasanya dimulai dari wajah, dada, tungkai dan kaki menjadi kuning. Biasanya hiperbilirubinemia dan sakit kuning akan menghilang setelah minggu pertama. Kadar bilirubin yang sangat tinggi biasanya disebabkan pembentukan yang berlebihan atau gangguan pembuangan bilirubin. Kadang pada bayi cukup umur yang diberi susu ASI, kadar bilirubin meningkat secara progresif pada minggu pertama, keadaan ini disebut jaundice ASI. Penyebabnya tidak diketahui dan hal ini tidak berbahaya, jika kadar bilirubin sangat tinggi mungkin perlu dilakukan terapi yaitu terapi sinar dan transfusi tukar. (Widagdo,2021).

6. Penyakit Yang Berhubungan dengan Ikterus Fisiologis
   a. Kern Ikterus

      Kern ikterus adalah: kelainan akibat kelebihan bilirubin merusak otak, terutama bagian ganglia basal, hipokampus, serebelum, dan nukleus dari lantai ventrikel keempat. Pada bayi baru lahir, kadar bilirubin yang sangat tinggi dapat menembus sampai ke otak hingga menimbulkan kerusakan otak. Bilirubin merupakan pigmen berwarna kuning kecokelatan yang ditemukan di dalam empedu, darah, dan tinja. Bilirubin berasal dari pemecahan hemoglobin di sel darah merah dan perombakan zat lain. Risiko kernikterus meningkat jika seseorang memiliki penyakit hemolitik yang tidak diobati dan kadar bilirubin lebih dari 25-30 mg/dL. Kelebihan bilirubin lebih berisiko pada bayi yang mengidap penyakit kuning pada 24 jam pertama kehidupan, riwayat saudara kandung pernah menerima fototerapi, ras Asia Timur, bayi laki-laki, usia ibu lebih dari 25 tahun, dan pengidap diabetes.
   b. Hipotiroid

      Pada keadaan bayi dengan fungsi kelenjar tiroid yang kurang normal yang disebut hipotiroid. Hormone tiroid bayi kurang jumlahnya. Akibatnya bayi bisa kuning memanjang dan lambat menurun. Bila bayi diberikan tambahan hormone tiroid, kuningnya lebih cepat hilang. Sebenarnya kuning pada keadaan ini tidak berbahaya, tetapi kekurangan hormone tiroid ini yang bisa berbahaya menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi terganggu dan dapat menurunkan IQ bayi nantinya bila terlambat diberikan tambahan hormone tiroid.

c. Infeksi Saluran Kemih

Bayi kuning dapat terjadi karena infeksi saluran kemih. Adanya bakteri dalam saluran kemih dapat membuat bayi terlihat kuning (peningkatan bilirubin indirek). Dokter biasanya akan meminta pemeriksaan urin rutin dan kultur urin untuk mencari kemungkinan infeksi saluran kemih. Dokter akan memberikan antibiotic yang sesuai untuk bayi apabila infeksi saluran kemih yang menjadi penyebabnya.

d. Atresia Bilier

Atresia bilier adalah penyakit hati dengan gejala kuning yang mengenai bayi. Gejala umumnya terlihat pada usia 2-8 minggu. Hati yang normal akan mengeluarkan empedu melalui saluran empedu dari hati ke usus 12 jari yang disebut juga duodenum. Pada atresia bilier, aliran empedu dari hati ke duodenum terhambat total, empedu tidak dapat mengalir sampai ke duodenum, akibatnya empedu tidak bisa sampai ke duodenum. Empedu akan tertahan di hati, empedu yang tertahan ini, mengandung asam empedu yang bila berlebihan dapat merusak hati dalam waktu cepat. Dalam 3 bulan hati dapat mengalami kerusakan hati hebat yang disebut serosis hati.

e. Ibu Diabetes Melitus

Bayi dari ibu hamil dengan diabetes mellitus yang selama hamilnya ibu mempunyai kadar gula darah yang tinggi , seringkali lebih besar dari bayi lain. Bila IDM tidak terkontrol maka lebih sering mengalami abortus atau lahir mati. Partus berlangsung sulit, dengan lebih sering trauma lahir. Manifestasi klinik pada bayi IDM ialah bayi terlihat besar untuk masa gestasi, wajah bulat, bayi

Nampak kemerahan, bercak kebiruan pada kulit, takikardia, takipneu, menangis lemah, hipoglikemia berat, Ikterus, malas minum, let alergi, tremor, atau gemetar atau menggigil segera setelah lahir. (Oktaria Mika,20121)

7. Penatalaksanaan Ikterus Fisiologis

Ikterus yang berhubungan dengan pemberian ASI disebabkan oleh peningkatan bilirubin indirek. Ada 2 jenis ikterus yang berhubungan dengan pemberian ASI, yaitu:

a. Jenis pertama: ikterus yang timbul dini (hari kedua atau ketiga) dan disebabkan oleh asupan makanan yang kurang karena produksi ASI masih kurang pada hari pertama.
b. Jenis kedua: ikterus yang timbul pada akhir minggu pertama, bersifat familiar, disebabkan oleh zat yang ada di dalam ASI yang biasanya disebut juga ikterus karna ASI. Karakteristik ikterus karena ASI adalah kadar bilirubin indirek yang masih meningkat setelah 4-8 hari pertama, berlangsung lebih lama dari ikerus fisiologis yaitu sampai 3-12 minggu dan tidak ada penyebab lainnya yang dapat menyebabkan ikterus. Ikterus karena ASI berhubungan dengan pemberian ASI dari seorang ibu tertentu dan biasanya akan timbul ikterus pada setiap bayi yang disusukannya. Selain itu, ikterus karena ASI juga bergantung kepada kemampuan bayi mengkonjugasi bilirubin indirek (misalnya bayi prematur akan lebih besar kemungkinan terjadi ikterus).

Bayi yang mendapat ASI eksklusif dapat mengalami ikterus. Ikterus ini disebabkan oleh produksi ASI yang belum banyak pada hari hari pertama. Bayi mengalami kekurangan asupan makanan sehingga bilirubin direk yang sudah mencapai usus tidak terikat oleh makanan dan tidak dikeluarkan melalui anus bersama makanan. Di dalam usus, bilirubin direk ini diubah menjadi bilirubin

indirek yang akan diserap kembali ke dalam darah dan mengakibatkan peningkatan sirkulasi enterohepatik. Keadaan ini tidak memerlukan pengobatan dan jangan diberi air putih at au air gula. Untuk mengurangi terjadinya ikterus dini perlu tindakan sebagai berikut:

1) Bayi Dalam Waktu 30 Menit Diletakkan Ke Dada Ibunya Selama 30-60 Menit
2) Posisi Dan Perlekatan Bayi Pada Payudara Harus Benar
3) Berikan kolostrum karena dapat membantu untuk membersihkan meconium dengan segera. Mekonium yang mengandung bilirubin tinggi bila tidak segera dikeluarkan, bilirubinnya dapat diabsorbsi kembali sehingga meningkatkan kadar bilirubin dalam darah.
4) Bayi Disusukan Sesuai Kemauannya Tetapi Paling Kurang 8 Kali Sehari.
5) Jangan Diberikan Air Putih, Air Gula Atau Apapun Lainnya Sebelum Asi Keluar Karena Akan Mengurangi Asupan Susu.
6) Monitor Kecukupan Produksi Asi Dengan Melihat Buang Air Kecil Bayi Paling Kurang 6-7 kali sehari dan buang air besar paling kurang 3-4 kali sehari (Widagdo, 2021).

D. Tinjauan Teori Manajemen Asuhan Kebidanan Menggunakan 7 langkah Varney Dengan Ikterus Fisiologis

1. Pengertian

Menurut Indrayani 2021, Manajemen kebidanan adalah: sebuah proses pemecahan masalah sistematis yang digunakan bidan untuk memberikan asuhan yang komprehensif kepada klien (ibu, keluarga, dan masyarakat). Proses ini melibatkan langkah-langkah logis yang meliputi pengkajian, analisis,

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan kesehatan yang optimal.

2. Langkah-langkah Dalam Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses sistematis yang terdiri dari 7 langkah utama menurut Varney, yaitu: pengumpulan data dasar, interpretasi data, identifikasi diagnosis atau masalah potensial, identifikasi kebutuhan yang membutuhkan tindakan segera, perencanaan asuhan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah-langkah ini digunakan untuk mengorganisasi pemikiran dan tindakan bidan secara logis dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien, dengan tujuan memastikan pemenuhan kebutuhan klien dan memecahkan masalah kesehatan yang mungkin timbul (Arhiyanti 2020). Adapun penjelasanya sebagai berikut:

a) Langkah I: Identifikasi Pengumpulan data dasar

1) Data Subjektif adalah data yang didapat dari pasien atau keluarga pasien suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak dapat ditentukan oleh tim kesehatan secara independen tetap melalui suatu interaksi atau komunikasi Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara dengan keluarga dan tim kesehatan yang lain, dimana wawancara tersebut untuk mengetahui pada ibu meliputi:

(a) Biodata: Menggunakan identitas menurut (Ambarwati 2021) yaitu:

(1) Nama Bayi: Untuk mengetahui identitas bayi dan menghindari kekeliruan.

(2) Umur Bayi: Untuk mengetahui usia bayi yang nantinya disesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan.

(3) Tanggal Lahir : Untuk mengetahui usia neonatus.

(4) Jenis Kelamin: Untuk mengetahui jenis kelamin bayi dan memastikan bahwa yang diperiksa benar-benar bayi yang dimaksud.

(5) Nama ayah/ibu: Untuk memudahkan memanggil atau menghindari kekeliruan.

(6) Umur: Untuk mengetahui apakah ibu termasuk resiko tinggi atau tidak.

(7) Pekerjaan: Untuk mengetahui tinggkat social ekonomi.

(8) Pendidikan: Berpengaruh dalam tindakan kebidanan dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat intelektualnya, sehingga bidan dapat memberikan konseling sesuai dengan pendidikanya.

(9) Suku/Bangsa: Berpengaruh pada adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari.

(10) Alamat : Untuk memudahkan komunikasi dan kunjungan rumah.

(b) Keluhan utama: Untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan ikterus neonatorum fisiologis (Ambarwati,dkk 2021). Pada ikterus neonatorum fisiologis, mengeluh kulit dan sklera mata bayi kuning, dan reflek menghisap serta menelan bayi lemah (Ambarwati,dkk, 2021).

(c) Riwayat kehamilan sekarang: Yang perlu dikaji adalah tanggal hari pertama haid terakhir, masalah dan kelainan pada kehamilan sekarang, pemakaian obat-obatan, keluhan selama hamil (Ambaewati, dkk 2021)

(d) Riwayat Penyakit Kehamilan dan Persalinan

(1) Riwayat Prenatal: Untuk mengetahui riwayat ANC (Ambarwati, dkk 2021). Pada riwayat kehamilan bisa disebabkan hipoksia ibu karena hipoventilasi akibat pemberian obat analgetik atau anestesi dalam. Berkurangnya aliran darah pada uterus akan menyebabkan berkurangnya pengaliran oksigen ke plasenta dan demikian pula ke janin. Hal ini sering ditemukan pada keadaan seperti gangguan kontraksi uterus misalnya hipertoni, hipotensi mendadak pada ibu perdarahan, hipertensi pada penyakit eklamsia (Ambarwati, dkk 2021).

(2) Riwayat persalinan sekarang: Untuk mengetahui berapa usia kehamilan ,waktu persalinan,jenis persalinan, lama kala 1, sampai kala 4, berat badan bayi, di tolong oleh siapa, adakah komplikasi dalam persalinan (Ambarwati, dkk 2021). Ikterus nenatorum fisiologis akan terjadi bila adanya jumlah sel darah merah yang lebih tinggi, keterlambatan pembuangan meconium, dan hati yang belum matang dalam memproses dan membuang bilirubin (Ambarwati, dkk 2021).

(e) Psikososial Budaya: Untuk mengetahui apakah ada pantangan makan atau kebiasaan yang tidak deperoleh selama hamil dalam adat

masyarakat setempat, perasaan tentang kehamilan ini, kehamilan ini direncanakan atau tidak, jenis kehamilan yang diharapkan, dukungan keluarga terhadap kehamilan ini, dan keluarga lain yang tinggal serumah

(f) Perokok dan pemakai obat-obatan: Dikaji untuk mengetahui kebiasaan merokok, menggunakan obat-obatan, dan alkohol (Ambarwati, dkk 2021).

(2) Data Objektif

Data ini dikumpulkan guna melengkapi data untuk menegakandiagnosa pada bayi (Ambarwati dkk, 2021).

2. Riwayat pemeriksaan khusus

Tabel APGAR Score

Tanda	**Nilai**		
	0	1	2
A: Appearance (Warna Kulit)	Seluruh tubuh kebiruan/pucat	Tubuh merah muda, tetapi tangan dan kaki kebiruan	Seluruh tubuh berwarna merah muda
Pulse (Detak Jantung)	Tidak ada detak jantung	Detak jantung <100x/m	Detak jantung >100x/m
Grimace (Respons Refleks)	Tidak ada respons sama sekali terhadap rangsangan	Bereaksi dengan meringis saat dirangsang	Batuk, bersin/menangis secara spontan saat diberi rangsangan

Activity (Tonus Otot)	Otot sangat lemah/lemas	Gerakan lambat/lemah	Gerakan aktif/ada gerakan spontan
Respiration (Pernapasan)	Tidak bernapas sama sekali	Pernapasan lambat/tidak teratur	Menangis kencang/pernapasan baik dan teratur

3) Pemeriksaan umum
   (1) Keadaan baik jika pasien memperlihatkan respon yang baik terhadap lingkungan dan orang lain, serta secara fisik tidak mengalami ketergantungan dalam berjalan (Sulistiyawati, 2021).
   (2) Lemah jika pasien dimasukan dalam kriteria ini jika kurang memberikan respon yang baik terhadap lingkungan dan orang lain dan pasien sudah tidak mampu lagi berjalan sendiri Pada kasus ikterus neonatorum fisiologis, bayi dalam keadaan lemah.

(c) Kesadaran: Menurut Ambarwati dkk (2021), kesadaran meliputi :
   (1) Composmentis adalah sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya.
   (2) Apatis adalah kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan kehidupan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh.
   (3) Somnolen adalah keadaan kesadaran yang mau tidur saja, dapat dibangunkan dengan rangsang nueri tetapi jatuh tidur lagi.
   (4) Delirium (semi koma) adalah kesadaran yang menyerupai koma.

(d) Tanda-tanda vital :

(1) Denyut jantung dinilai kecepatan, irama, kekuatan, dalam satu menit normalnya 120-160x/menit. Pada kasus ikterus neonatorum fisiologis merupakan kondisi umum dan tidak berbahaya di mana kulit dan sklera mata bayi kuning akibat penumpukan bilirubin yang tidak berbahaya, dan tidak secara langsung mempengaruhi denyut jantung.

(2) Pernapasan dinilai dari sifat pernapasan dan bunyi napas dalam satu menit, pernapasan normal adalah 40- 60x/menit. Pada kasus ikterus neonatorum fisiologis tidak secara langsung berpengaruh pada pernapasan.

(3) Suhu dinilai dari temperatur normal rectal dan axilla yaitu 36,5°C sampai

(e) Menurut pemeriksaan fisik sistematis meliputi:

i. Kepala: Pemeriksaan terhadap ukuran, sutura menutup atau terbuka, adanya caput succedaneum, kraniotabes, dan sebagainya.

ii. Muka: Warna kulit merah atau tidak, simetris atau tidak, adakah chepal hematoma atau tidak.

iii. Mata: Simetris atau tidak, warna conjungtiva pucat atau tidak, ada sklera ikterus

iv. Mulut: Reflek hisap baik atau tidak, bibir kering atau tidak, adakah kelainan palatum atau tidak.

v. Hidung: Simetris atau tidak, bersih atau tidak, tidak atau ada pernafasan cuping hidung. Pada kasus bayi asfiksia berat tidak ada usaha untuk bernapas.

vi. Telinga: Simetris atau tidak, bersih atau tidak adakah kelainan.

vii. Leher: Untuk mengetahui pembesaran kelenjar tiroid dan bendungan vena juga laris.

viii. Dada: Simetris atau tidak, adakah retraksi dinding dada atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak

ix. Tali pusat: Bersih atau tidak,adakah pendarahan atau tidak, terbungkus kasa atau tidak.

x. Abdomen:Simetris atau tidak, adakah perdarahan tali pusat atau tidak, adakah tanda- tanda infeksi atau tidak.

xi. Genetalia: Jika laki-laki apakah testis sudah turun pada skrotum, jika perempuan apakah labia mayora sudah menutupi labia minora.

xii. Ekstremitas: Simetris atau tidak, jumlah jari tangan lengkap atau tidak dan kaki lengkap atau tidak, adakah polidaktili atau tidak. Pada kasus bayi asfiksia berat warna kulitnya biru pucat.

xiii. Anus : Apakah anus berlubang atau tidak.

(f) Pemeriksaan Reflek

(1) Reflek Morro: Apabila bayi diberi sentuhan mendadak terutama dengan jari dan tangan, maka menimbulkan gerak terkejut. Pada bayi asfiksia berat gerak reflek terkejut tidak ada karena bayi lemah.

(2) Reflek Grasping: Apabila telapak tangan bayi di sentuh dengan jari pemeriksa, maka bayi akan berusaha menggengam jari pemeriksa. Pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat reflek menggenggam masih lemah.

(3) Reflek Rotting: Apabila pipi bayi disentuh oleh jari pemeriksa, maka

bayi akan menoleh dan mencari sentuhan itu. Pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat reflek menoleh masih lemah.

(4) Reflek Sucking: Apabila bayi di beri dot atau puting, maka bayi berusaha untuk menghisap. Pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat reflek menghisap masih lemah.

(5) Reflek Tonic Neck: Reflek yang timbul jika bayi mengangkat leher dan Menoleh

(g) Pemeriksaan Antropometri

Menurut Ambarwati dkk (2021), pemeriksaan antropometri meliputi:

(1) Lingkar Kepala: Normal pada bayi baru lahir antara 33-38 cm.

(2) Lingkar Dada: Normal pada bayi baru lahir antara 30-35 cm.

(3) Panjang Badan: Nomal pada bayi baru lahir antara 48-52 cm.

(4) Berat badan: Normal berat badan bayi baru lahir antara 2500 gram sampai 4000 gram.

(h) Nutrisi

Kebutuhan nutrisi pada bayi baru lahir hari pertama 60 cc/kg BB, selanjutnya di tambah 30 cc/kg BB

(i) Eliminasi

a. Urine: Pengeluaran urine pada bayi baru lahir terjadi 24 jam pertama setelah lahir. Urine yang normal berwarna kuning

b. Mekonium: Pengeluaran mekonium pada bayi baru lahir normal agak lembek dan berwarna hitam kehijauan

(j) Data Penunjang

Pemeriksaan untuk menunjang diagnosis penyakit guna mendukung atau menyingkirkan diagnosis lainnya

b) Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Mengidentifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yangtelah dikumpulkan. Dalam langkah ini data yang dikumpulkan diinterpretasikan menjadi diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap pasien (Ambarwati dkk, 2021).

(a) Diagnosa kebidanan

Diagnosa dapat di tegakkan yang berkaitan (Ambarwati, 2021) Diagnosa kebidanan pada kasus ini ialah “Bayi Ny. F dengan Ikterus Neonatorum Fisiologis”.

Dengan data dasar meliputi:

(1) Data Subjektif

1. Ibu mengatakan HPHT tanggal 20 November 2024
2. Ibu mengatakan bayinya lahir pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 13:12 WIT
3. Ibu mengatakan usia kehamilan 40 minggu 3 hari
4. Ibu mengatakan bayinya tidak menyusui dengan baik dimulai pada 25 Agustus 2025

(2) Data Objektif

(a) Kulit dan sklera mata bayi F terlihat kuning
(b) Refleks menghisap dan menelan bayi F lemah
(c) Hasil pemeriksaan laboratorium bayi f 13 mg/dl

(3) Masalah

Permasalahan yang muncul berdasarkan pernyataan (Ambarwati dkk, 2021), dalam asuhan kebidanan pada neonatus dengan masalah ikterus neonatorum fisiologis adalah *kern ikterus*

(4) Kebutuhan

Dalam bagian ini bidan menentukan kebutuhan pasien berdasarkan keadaan dan masalahnya, dengan semikian Kebutuhan pada neonatus dengan masalah ikterus neonatorum yaitu melakukan pemberian foto terapi

c) Langkah III: Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang mungkin akan terjadi. Pada langkah ini diidetifikasikan masalah atau diagnose potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa, hal ini membutuhkan antisipasi, pencegahan, bila memungkinkan menunggu mengamati dan bersiap-siap apabila hal tersebut benar-benar terjadi (Ambarwati dkk, 2021). Bila proses ini berlangsung terlalu jauh dapat mengakibatkan kerusakan otak atau kematian Pada bayi.

d) Langkah IV: Identifikasi tindakan segera / kolaborasi

Dalam penatalaksanaannya terkadang bidan dihadapkan pada beberapa situasi yang memerlukan penanganan segera (emergensi) di mana bidan harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasien, namun kadang juga berada pada situasi pasien yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter, atau bahkan mungkin juga situasi pasien yang memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain Antisipasi dalam kasus bayi dengan masalah ikterus fisiologis adalah berkolaborasi dengan dokter dalam melakukan pemberian foto terapi pada bayi F

e) Langkah V: Perencanaan (Intervensi)

Langkah-langkah ini ditentukan oleh langkah- langkah sebelumnya yang merupakan lanjutan dari masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau di antisipasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah dilihat dari kondisi pasien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga berkaitan dengan kerangka pedoman antisipasi bagi bayi tersebut yaitu apa yang akan terjadi berikutnya (Ambarwati dkk, 2021). Pada neonatus dengan masalah ikterus fisiologis yaitu: mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi F, mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital pada bayi F setiap 3 jam, menjaga kehangatan bayi F, memberikan nutrisi pada bayi f berupada susu formula sebagai penganti ASI untuk memenuhui nutrisi pada bayi F sebanyak 3 cc/3 jam, menganti pakaian dan popok bayi, melakukan pemberian foto terapi pada bayi F, memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan dan kondisi yang dialami oleh bayi F kepada keluarga.

f) Langkah VI: Penatalaksanaan (Implementasi)

Langkah ini merupakan pelaksanaan rencana asuhan penyuluhan pada klien dan keluarga (Ambarwati dkk, 2021). Pada neonatus dengan masalah ikterus fisiologis yaitu: mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi F, mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital pada bayi F setiap 3 jam, menjaga kehangatan bayi F, memberikan nutrisi pada bayi f berupada susu formula sebagai penganti ASI untuk memenuhui nutrisi pada bayi F sebanyak 3 cc/3 jam, menganti pakaian dan popok bayi, melakukan pemberian foto terapi pada bayi F.

berikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan dan kondisi yang dialami oleh bayi F kepada keluarga.

g) Langkah VII: Evaluasi

Langkah ini merupakan langkah terahir guna mengetahui apa yang telah dilakukan bidan. Mengevaluasi keefektifan dari asuhan yang diberikan, ulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap setiap aspek asuhan yang sudah dilaksanakan tapi belum efektif atau merencanakan kembali yang belum terlaksana. (Ambarwati,dkk 2021).

Hasil yang diharapkan dari asuhan kebidanan neonatus dengan ikterus fisiologis adalah: kebersihan dan kehangatan bayi F tetap terjaga, nutrisi bayi F tetap terjaga, reflex menghisap dan menelan bayi F kembali baik, kulit dan sklera mata bayi F tidak lagi menguning

2. Pendokumentasian Asuhan Kebidana (SOAP)

Format SOAP pada umumnya digunakan untuk melakukan pengkajian data awal pada pasien. Adapun langkah-langkah pada SOAP itu sendiri antara lain:

a. S: Data Subjektif (Mengambarkan pendokumentasian yang dimana bagian ini mencatat informasi yang berasal dari pasien atau keluarganya)
b. O: data Objektif (Mengambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien yang didapatkan dari hasil oservasi, atau ditemukan secara langsung oleh tenaga medis)
c. A: *Assesment* (Merupakan masalah yang ditegakan berdasarkan analisa data subjektif dan objektif untuk membuat penilaian atau diagnosis yang isinya

Kesimpulan dari data yang dikumpulkan, termasuk diagnosis yang mungkin, prognosis, atau interpretasi kondisi pasien berdasarkan keahlian klinis)

d. P: Planning/Perencanaan (Mengambarkan pendokumentasian dari perencanaan dan evaluasi yang didalamnya berisi rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien)

BAB III

TINJAUN KASUS

MANAJAMEN ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS PADA BAYI "F" DENGAN IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH SAKIT TK II PROF DR.J.A LATUMETEN AMBON

No. Register	: 33/xxx/xxxx
Tanggal Masuk/Jam	: 26 Agustus 2025/ 17:15. WIT
Tanggal Persalinan	: 25 Agustus 2025/15:12 WIT
Tanggal Pengkajian/Jam	: 26 Agustus 2025/ 19:00 WIT
Tempat	: Ruang NICU
Nama Pengkaji	: Hesty Sintia Septory

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar

1. Identitas Pasien
   a. Identitas Bayi

Nama	: By Ny "F"
Umur	: 1 hari
Tempat tangal lahir	: Ambon, 25 Agustus 2025
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Anak Ke	: 1

   b. Identitas Orang Tua

Ibu	Bapak
NamaIbu: Ny F	Tn: L
Umur: 25 Thn	26 Thn
Pendidikan: SI	SI
Pekerjaan : IRT	Wiraswasta
Alamat: Batu Merah	Batu Merah
Suku/Bangsa: Maluku	Maluku

Agama: Islam	Islam
No. Telp: 081244576603	081244576603

c. Riwayat Kesehatan

a. Keluhan Utama

Ibu mengatakan Kulit dan sklera anaknya tampak kuning, dan reflek menghisapnya perlahan

b. Riwayat Kesehatan

Tidak ada riwayat penyakit hipertensi, jantung, tiroid, alergi, autoimun, asma, TB, hepatitis B, jiwa, sifilis, tidak ada riwayat alergi dan tidak ada riwayat penyakit menular seksual seperti HIV/ AIDS

c. Riwayat Kesehatan Kehamilan

Anak pertama, tidak perna keguguran, HPHT : 20 November 2024, TP (Tafsiran Persalinan) yaitu tanggal 27 Agustus 2025, gestasi 40 minggu 3 hari, selama hamil ibu mengonsumsi tablet FE, kalsium, asam folat, dan susu ibu hamil.

d. Riwayat Imunisasi

Bayi telah mendapatkan Imunisasi HB0 dan Vit K pada pukul 13:15 setelah bayi lahir

e. Riwayat Pemenuhan Gizi:

1) Nutrisi/cairan

Bayi sudah diberikan susu formula sebagai pemenuhan nutrisi cairan sebagai penganti ASI ibu

2) Personal Hygiene

Bayi sudah dimandikan, pakaian dan popok bayi sudah diganti

3) Eliminasi

Bayi sudah BAB dan BAK selama pengkajian, dengan frekuensi untuk BAB 1x, warna hijau kehitaman, tekstur kental, Dan untuk BAK frekuensi 1x, warna kuning jernih, bau amoniak

d. Data Psikologis, Spiritualitas, dan Ekonomi

1) Kedua orang tua bayi sangat bahagia dengan kelahiran bayinya tetapi merasa sedih karena bayinya tampak kuning
2) Orang tua bayi dapat bekerja sama dengan petugas kesehatan dalam perawatan bayinya khususnya dalam pemberian ASI
3) Kedua orang tua berharap agar nutrisi bayinya dapat terpenuhi dengan ASI
4) Orang tua selalu mendoakan bayinya agar bayinya dapat segera pulih
5) Hubungan ibu, suami dan lingkungan sekitarnya baik
6) Penghasilan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
7) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami

B. Data Objektif

1. Pemeriksaan Umum

Keadaan Umum : Cukup baik

Kesadaran : Composmentis

Frekuensi Jantung : 120 x/menit

Suhu : 36,5°c

Pernapasan : 42 x/menit

Nilai Apgar : 8/10

Tabel 3.1 Penilaian Nilai APGAR Score Pada Bayi F

No	Kriteria	1 Menit	5 Menit	10 Menit
1	Denyut jantung	2	2	2
2	Usaha Nafas	1	2	2
3	Tonus Otot	2	2	2
4	R efleks	1	2	2
5	Warna Kulit	2	2	2
	Total	8	10	10

Sumber data primer bayi "F" tahun 2025

2. Pemeriksaan Antropometri

Berat Badan : 2.600 Kg

Panjang Badan : 48 cm

Lingkar Kepala : 34 cm

Lingkar Dada :36 cm

Lingkar Perut :35 cm

3. Pemeriksaan Fisik

a. Kepala: Bentuk kepala bulat, tidak terdapat benjolan, rambut tipis, berwarna hitam, dan tidak ada caput sucsadenum

b. Wajah: Tidak ada oedema, warna kulit kuning
c. Mata: Sklera mata kuning, konjungtiva merah muda
d. Hidung: Tidak ada secret, tidak ada pernapasan cuping hidung
e. Mulut: Tidak terdapat kelainan pada mulut, mukosa mulut berwarna merah muda dan lembab
f. Telinga: simetris kiri dan kanan, bersih, tidak ada serumen, warna kulit kuning
g. Leher: Tidak ada benjolan
h. Dada: simteris kiri dan kanan, tidak ada benjolan dan tampak berwarna kuning
i. Abdomen: tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat
j. Ekstremitas: Ekstremitas atas tidak terdapat kelainan karna terdapat jari-jari yang lengkap dan memiliki warna kulit kuning, sedangkan untuk ekstremitas ekstremitas bawah tidak terdapat kelainan karna terdapat jari-jari yang lengkap, dan memiliki warna kulit bawah kemerahan
k. Genetalia: &Anus: Pada genetalia dan anus tidak terdapat kelainan, pada anus terdapat lubang anus
l. Refleks:
   a) *Moro*/Terkejut (bayi memperlihatkan reaksi ketika disentuh secara tidak sengaja)
   b) *Rooting*/Mencari (Bayi mencari dot saat dot didekatkan dan menyentuh mulut bayi)
   c) *Sucking*/Menghisap (Bayi menghisap dot secara perlahan saat hendak diberi susu)
   d) *Swallowing*/Menelan (Bayi menelan susu dengan perlahan)

e) *Graps*/Menggenggam (bayi akan mengenggam ketika jari kita bertemu dengan jari bayi).

4. Eliminasi

a. Buang Air Kecil

Bayi telah Buang Air Kecil selama pengkajian selama 1x

b. Buang Air Besar

Bayi telah Buang Air Besar selama pengkajian selama 1x

5. Pemeriksaan Penunjang

a. Laboratorium

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan laboratorium pada bayi "F"

No	Tanggal/Jam	Hasil pemeriksaan laboratorium	Normal
1	26-Agustus-2025 Pukul 17:00 WIT	bilirubin total : 13 mg/dl	Bilirubin total : <10 mg/dl pada bayi prematur. < 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan.

Sumber data primer bayi "F" tahun 2025

b. Terapi yang di dapat: Foto terapi dan pemenuhuhan nutrisi cairan seperti pemberian susu formula sebagai pengganti ASI Ibu

Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

1. Diagnosa Aktual : Bayi Ny "F", usia 1 hari, BCB, SMK, dengan ikterus fisiologis derajat 2.

2. Data subjektif :
   a. Ibu bayi “F” mengatakan HPHT tanggal 20 November 2024
   b. Ibu bayi “F” mengatakan melahirkan tanggal 25 Agustus 2025 pukul 15.12 WIT
   c. Gestasi usia kehamilan 40 minggu 3 hari
   d. Ibu bayi “F” mengatakan kulit dan sklera bayinya terlihat kuning pada tanggal 26 Agustus 2025 pada pukul 17:00 WIT
   e. Ibu bayi “F” mengatakan bayinya tidak menyusui dengan baik dimulai dari tanggal 25 Agustus 2025
3. Data Objektif
   a. Kulit dan sklera mata bayi “F” terlihat kuning
   b. Refleks menghisap dan menelan bayi “F” lemah
   c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium bayi “F” 13 mg/dl

   Analisa dan interpretasi data:

   a. Bayi cukup bulan adalah bayi yang dilahirkan dengan usia gestasi 37 – 42 minggu (Sarwono, 2022: 414). Dari hasil pengkajian pada kasus bayi “F” hari pertama haid terakhir ibu pada tanggal 20 November 2024 sampai bayi lahir tanggal 25 Agustus 2025, berarti bayi lahir pada usia kehamilan 40 minggu 3 hari sehingga bayi termasuk kategori Bayi Cukup Bulan (BCB).
   b. Bayi lahir sesuai dengan masa kehamilan adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir 2500 – 4000 gram dengan usia gestasi 37 – 42

minggu (Sarwono, 2022: 414). Dari hasil pengkajian pada kasus bayi “F” lahir pada usia kehamilan 40 minggu 3 hari dengan berat badan lahir 2600 gram. Berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan lahir bayi “F” dengan usia kehamilan 40 minggu 3 hari sudah Sesuai Masa Kehamilan (SMK).

c. Ikterus adalah warna kuning di kulit dan sklera yang terjadi karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Produksi bilirubin sebagian besar berasal dari pemecahan sel darah merah yang menua (80%), (Maryunani A,2022). Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “F” didapatkan kulit dan sklera bayi nampak kuning, bayi balas minum yang ditandai dengan refleks menghisap dan menelan bayi lemah, artinya bayi tersebut mengalami Ikterus.

d. Masalah yang sering dijumpai pada bayi dengan ikterus adalah bayi tidak mau minum ASI, refleks isap dan menelan minuman (Manuaba,2022). Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “F” bayi malas minum, refleks isap dan menelannya lemah.

Langkah III. Antisipasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Diagnosa potensial: *Kern Ikterus*

Langkah IV. Tindakan Segera/*Emergency Dan Kolorasi*

Melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian Foto Terapi yang dilakukan selama dua hari dengan tujuan dapat menurunkan kadar bilirubin pada bayi F dan pemberian susu formula sebagai penganti ASI per 3 jam sebanyak 3 cc untuk memenuhi nutrisi cairan penganti ASI Ibu

Langkah V. Perencanaan

Tanggal: 26 Agustus 2025 Jam: 19:30WIT

1. Tujuan : Dapat mengurangi kuning pada kulit bayi
2. Kriteria : Kulit bayi tampak kuning
   1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi Ny "F"

      Rasional : Untuk mencegah terjadinya infeksi
   2) Mengobservasi Keadaan Umum dan tanda-tanda vital pada bayi Ny "F" tiap 3 jam

      Rasional : Untuk memantau keadaan pasien dan mencegah terjadinya komplikasi.
   3) Menjaga kehangatan bayi "F"

      Rasional : Untuk mempertahankan suhu bayi
   4) Memberikan nutrisi pada bayi Ny "F" berupa susu formula sebagai pengganti ASI Ibu

      Rasional : Untuk memenuhi nutrisi cairan pada bayi Ny "F"
   5) Mengganti pakaian dan popok bayi

      Rasional : Agar kenyamanan bayi tetap terjaga
   6) Melakukan pemberian foto terapi pada bayi Ny "F"

      Rasional : Untuk membantu menurunkan atau mencegah peningkatan kadar bilirubin tak terkonjugasi yang dapat bersifat neurotoksik pada bayi baru lahir.
   7) Memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan dan kondisi yang dialami bayi kepada keluarga

Rasional : Untuk meningkatkan pemahaman dan menurunkan rasa takut dari keluarga terhadap situasi yang sedang terjadi

Langkah VI. Penatalaksanaan

Tanggal: 26 Agustus 2025 Jam: 19: 50 WIT

1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi Ny "F"
   Hasil : Kondisi tangan selalu bersih dan steril sebelum dan sesudah kontak dengan bayi
2) Observasi Keadaan Umum bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam
   Hasil :

Tabel 3.3 Hasil Observasi TTV pada bayi "F"

Jam	Frekuensi jantung	Pernafasan	Suhu
20:00	120 x/menit	42 x/menit	36,5°C
23:00	120x/menit	42x/menit	36,5°C
02:00	122x/menit	44x/menit	$36,6^0$ C

3) Menjaga kehangatan bayi
   Hasil : Kehangatan bayi sudah terjaga, karena setiap bayi dikeluarkan dari incubator akan dibedong
4) Memberikan cairan berupa susu formula sebagai penganti ASI ibu
   Hasil : Bayi sudah diberikan susu formula sebagai penganti asi dalam pemenuhan nutrisi cairan setiap 3 jam sekali
5) Mengganti pakaian dan popok bayi
   Hasil : Pakaian dan popok bayi sudah diganti

6) Melakukan pemberian foroterapi pada bayi Ny “F”
   Hasil : Telah dilakukan pemberian foto terapi pada bayi Ny “F” di tanggal 26 agustus 2025 pukul 18:00 WIT
7) Berikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan dan kondisi yang dialami bayi kepada keluarga, bahwa keadaan yang dialami bayinya adalah masalah umum yang seringkali terjadi pada bayi baru lahir dan akan hilang pada 1-2 minggu karena merupakan kondisi normal pada bayi baru lahir
   Hasil : Keluarga telah mengetahui tentang penjelasan dan kondisi yang dialami bayi serta kecemasan yang dialami keluarga sudah berkurang

Langkah VII. Evaluasi

Tanggal: 26 Agustus 2025 Jam: 20:20

1) Kebersihan dan kenyamanan pada bayi Ny “F” tetap terjaga
2) Telah dilakukan pemantauan TTV pada bayi Ny “F” setiap 3 jam sekali
3) Kehangatan tubuh bayi “F” tetap terjaga
4) Pemberian cairan nutrisi sebagai pengganti ASI Ibu pada bayi Ny“F” telah dilakukan setiap 3 jam sekali
5) Kebersihan bayi “F” tetap terjaga
6) Telah dilakukan pemberian foto terapi pada bayi Ny“F” tanggal 26 agustus 2025 pukul 18:00 WIT
7) Ibu telah mengetahui tentang keadaan bayi Ny “F” setelah dijelaskan

PENDOKUMENTASIAN HASIL MANAJAMEN ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS PADA BAYI "F" DENGAN IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH SAKITTK II PROF

DR.J.A LATUMETEN AMBON

No Register	:33xx/xxxx
Tanggal Masuk	: 26 Agustus 2025/17:15 WIT
Tanggal Persalinan	: 25 Agustus 2025/15:12 WIT
Tanggal Pengkajian	: 26 Agustus 2025/19:00 WIT
Nama Pengkaji	: Hesty Sintia Septory
Tempat	: Ruang Nicu

A. Identitas Pasien

1. Identitas Bayi

Nama	: By Ny "F"
Umur	: 1 hari
Tempat tangal lahir	: Ambon, 25 Agustus 2025
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Anak Ke	: I

2. Identitas Orang Tua

Nama Ibu	: Ny F	Nama Suami	: Tn L
Umur	: 25 Thn	Umur	: 26 Thn

Agama	: Islam	Agama	: Islam
Suku/Bangsa	: Maluku	Suku/Bangsa	: Maluku
Pendidikan	: S1	Pendidikan	: S1
Pekerjaan	: Wiraswasta	Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Batu Merah	Alamat	: Batu Merah
No. Telp	: 081244576603	No. Telp	: 081244576603

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ini merupakan anak pertama, dan sebelumnya tidak pernah mengalami keguguran
2. Ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 25 Agustus 2025 di jam 15:12 WIT
3. Ibu menjelaskan kondisi umum bayinya yang dimana pada tanggal 25 agustus 2025 bayi tidak menggalami kuning, sklera mata putih, kulit bayi kemerahan, dan tidak ada kelainan
4. Ibu mengatakan bayi “F” tidak menyusui dengan baik dimulai dari tanggal 25 Agustus 2025
5. Ibu mengatakan merasa khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 26 Agustus 2025 pukul 17:00.

Data Objektif (O)

1. Keadaan Umum bayi cukup baik
2. Kesadaran : compos mentis
3. Hasil Pemeriksaan TTV pada bayi “F” tgl 26 agustus 2025

   Frekuensi Jantung : 120 x/menit

   Suhu : 36,5°c

Pernapasan : 42 x/menit

4. Refleks *moro*/terkejut (bayi memperlihatkan reaksi ketika disentuh secara tidak sengaja), *rooting/*mencari (bayi mencari botol susu saat botol susu didekatkan dan menyentuh mulut bayi), *sucking*/menghisap (bayi menghisap dot dengan perlahan saat hendak diberi susu), *swallowing*/menelan (bayi menelan dengan perlahan) graps /menggenggam (bayi akan mengenggam ketika jari kita bertemu dengan jari bayi)
5. Eliminasi
   a. Bayi sudah BAK selama pengkajian selama 1x
   b. Bayi sudah BAB selama pengkajian selama 1x

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Bayi "F" dengan ikterus neonatorum fisiologi

Masalah aktual : Gangguan kebutuhan pemenuhan nutrisi

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya *kern ikterus*

Planning (P)

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi "F"
2. Observasi Keadaan Umum bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam

Tabel 3.3 Hasil Observasi TTV pada bayi F

Jam	Frekuensi jantung	Pernafasan	Suhu
20:00	120 x/menit	42 x/menit	36,5°C
23:00	120x/menit	42x/menit	36,5°C

03:00	122x/menit	44x/menit	$36,6^0$ C

3. Menjaga kehangatan suhu tubuh bayi
4. Memberikan cairan berupa susu formula sebagai penganti ASI ibu
5. Mengganti pakaian dan popok bayi
6. Melakukan pemberian foroterapi pada bayi Ny “F”
7. Berikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan dan kondisi yang dialami bayi kepada keluarga, bahwa keadaan yang dialami bayinya adalah masalah umum yang seringkali terjadi pada bayi baru lahir dan akan hilang pada 1-2 minggu karena merupakan kondisi normal pada bayi baru lahir

PENDOKUMENTASIAN HASIL MANAJAMEN ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS PADA BAYI "F" HARI KE II DENGAN IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH SAKIT TK II PROF DR.J.A LATUMETEN AMBON

No. Register	: 333/xx/xxxx
Tanggal Masuk/Jam	: 26 Agustus 2025/ 17:15. WIT
Tanggal Persalinan	: 25 Agustus 2025/15:12 WIT
Tanggal Pengkajian/Jam	: 27 Agustus 2025/ 10:00 WIT
Nama Pengkaji	: Hesty Sintia Septory
Tempat	: Ruang NICU

1. Identitas Bayi

Nama	: By "F"
Umur	: 2 hari
Tempat tangal lahir	: Ambon, 25 Agustus 2025
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Anak Ke	: 1

Data Subjektif (S)

1. Bayi "F" masih dirawat di ruang NICU di hari kedua
2. Pemasangan foto terapi pada bayi "F" masih diberikan
3. Kulit bayi "F masih terlihat kuning
4. Keadaan umum bayi "F" cukup baik
5. Bayi sudah buang air besar sebanyak 2 kali dan buang air kecil sebanyak 3 kali

Data Objektif (O)

a) Hasil pemeriksaan TTV

Frekuensi Jantung	: 122 x/menit
Suhu	: 36,6°c
Pernapasan	: 44 x/menit
Berat Badan	: 2.600 gram

b) Pada kulit dan sklera mata bayi tampak kekuningan

c) Reflek: moro/terkejut (bayi memperlihatkan reaksi ketika disentuh secara tidak sengaja), rooting/mencari (bayi mencari botol susu saat botol susu didekatkan dan menyentuh mulut bayi), sucking/menghisap (bayi menghisap dot dengan perlahan saat hendak diberi susu), swallowing/menelan (bayi menelan dengan perlahan) graps /menggenggam (bayi akan mengenggam ketika jari kita bertemu dengan jari bayi)

d) Eliminasi

Bayi sudah suang air kecil sebanyak 2 kali dan buang air besar sebanyak 2 kali

Assesment (A)

Diagnosa aktual : bayi “ F “ dengan ikterus Fisiologi hari ke 2

Diagnosa Potensial : Potensial terjadinya kern ikterus

Planning (P)

Tanggal 27 Agustus 2025 Pukul 11:00 WIT

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi “F”
2. Observasi Keadaan Umum bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam

Tabel 3.3 Hasil Observasi TTV pada bayi "F" (27-08-2025)

Jam	Frekuensi jantung	Pernafasan	Suhu
11:05	120 x/menit	42 x/menit	36,5°C
14:05	120x/menit	42x/menit	36,5°C
17:05	122x/menit	44x/menit	$36,6^0$ C

3. Menjaga kehangatan bayi
4. Memberikan cairan berupa susu formula sebagai penganti ASI ibu
5. Menganti pakaian dan popok bayi
6. Melakukan pemberian foroterapi pada bayi Ny "F"
7. Berikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan dan kondisi yang dialami bayi kepada keluarga, bahwa keadaan yang dialami bayinya adalah masalah umum yang seringkali terjadi pada bayi baru lahir dan akan hilang pada 1-2 minggu karena merupakan kondisi normal pada bayi baru lahir

PENDOKUMENTASIAN HASIL MANAJAMEN ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS PADA BAYI "F" HARI KE III DENGAN IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH SAKIT TK II PROF DR.J.A LATUMETEN AMBON

Tanggal Masuk/Jam	: 26 Agustus 2025/ 17:15. WIT
Tanggal Partus/Jam	: 25 Agustus 2025/15:12 WIt
Tanggal Pengkajian/Jam	: 28 Agustus 2025/ 10:00 WIT
Nama Pengkaji	: Hesty Sintia Septory
Tempat	: Ruang NICU

1. Identitas Bayi

Nama	: By Ny "F"
Umur	: 3 hari
Tempat tangal lahir	: Ambon, 25 Agustus 2025
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Anak Ke	: 1

Data Subjektif (S)

a) Keadaan umum bayi "F" sudah baik hari ketiga
b) Kulit bayi dan sklera mata sudah tidak lagi menguning
c) foto terapi pada bayi "F" sudah dilepaskan
d) Reflek menghisap dan menelan bayi "F" sudah kuat
e) Bayi "F" sudah di waslap dan dipersiapkan untuk pulang di jam 12:00 WIT

Data Objektif (O)

1. Keadaan Umum bayi baik
2. Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung	: 124x/menit
Pernapasan	: 46x/menit

Suhu : $36,5^0$ C

3. pemeriksaan Fisik:
   a. Kepala: Bentuk kepala bulat, tidak terdapat benjolan, rambut tipis, berwarna hitam, dan tidak ada caput sucsadenum
   b. Wajah: Tidak ada oedema
   c. Mata: Pada Sklera mata tidak tampak ikterik, sedangkan pada konjungtiva berwarna merah muda
   d. Hidung: Tidak ada secret, pernapasan sesuai dengan gerakan dada
   e. Mulut: Tidak terdapat kelainan pada mulut, mukosa mulut berwarna merah muda dan lembab
   f. Telinga: simetris kiri dan kanan, bersih, tidak ada serumen
   g. Leher: Tidak ada benjolan, pernapasan sesuai dengan gerakan dada
   h. Dada: simteris kiri dan kanan, tidak ada benjolan
   i. Abdomen: tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat
   j. Ektremitas: Tidak terdapat kelainan dan warna ekstremitas sudah kembali merah
   k. Genetalia: &Anus: Pada genetalia dan anus tidak terdapat kelainan, pada anus terdapat lubang anus
   l. Refleks:
      2) Moro/Terkejut (bayi memperlihatkan reaksi ketika disentuh secara tidak sengaja)
      3) Rooting/Mencari (Bayi mencari dot saat dot didekatkan dan menyentuh mulut bayi)
      4) Sucking/Menghisap (Bayi menghisap dot dengan baik saat hendak diberi susu)
      5) Swallowing/Menelan (Bayi menelan susu dengan baik)
      6) Graps/Menggenggam (bayi akan mengenggam ketika jari kita bertemu dengan jari bayi).
4. Eliminasi

   Bayi sudah buang air kecil sebanyak 2 kali dan buang air besar sebanyak 1 kali

5. Pemeriksaan Penunjang: 5 mg/dl

Assement (A)

Bayi Ny “ F ” dengan keadaan normal di hari ketiga

Planning (P)

Tanggal 28 Agustus pukul 11:00 WIT

1. Mencuci tangan sebelum dan sesuda melakukan tindakan pada bayi Ny “F”
2. Mengobservasi Keadaan Umum bayi

   Hasil :

   Keadaan Umum bayi baik

   Tanda-Tanda Vital

   Frekuensi jantung : 124x/i

   Pernapasan : 46x/i

   Suhu : $36,5^0$ C
3. Mendampingi bidan dalam mempersiapkan bayi untuk pulang
4. Memberikan informasi kepada orang tua bayi bahwa hari ini bayinya sudah diperbolehkan untuk pulang
5. Memberikan KIE pada orang tua bayi mengenai: Pemberian ASI, Pencegahan ikterus, Pencegahan hipotermi, Tanda-tanda bayi sakit, Personal hygiene, imunisasi.

BAB IV
PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan ikterus fisiologis pada bayi Ny,F di Rumah Sakit TK II Prof Dr J.A Latumeten Ambon, maka penulis akan membahas permasalan yang akan timbul pada kasus bayi dengan ikterus fisiologis dengan membandingkan kesenjangan antara teori dan kasus yang ada, adapun pembahasan dalam bentuk narasinya adalah sebagai berikut:

1. Langkah I: Pengkajian Data dan Analisa Data

   Pada langkah ini kita menghimpun informasi tentang klien atau orang yang meminta asuhan dan memilih informasi yang tepat diperlukan analisa. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

   a) Anamnesa, meliputi:

      Melakukan tanggung jawab untuk memperoleh data meliputi, biodata pasien, keluhan utama waktu masuk, riwayat penyakit, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dan riwayat operasi.

   b) Pemeriksaan Fisik, meliputi:

      Keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik yang

      dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang

      bila perlu.

      Pada tahap pengkajian dengan teori ikterus fisiologi adalah tidak melewati kadar yang membahayakan atau yang mempunyai potensi menjadi kern ikterus dan tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi, Ikterus fisiologi bisa juga disebabkan karena hati dalam bayi tersebut belum matang, atau disebabkan kadar penguraian sel darah merah yang cepat, Dalam kadar tinggi bilirubin

bebas ini bersifat racun sulit larut dalam air, Masalahnya organ bayi sebagian bayi baru lahir belum dapat berfungsi optimal dalam mengeluarkan bilirubin tersebut. Barulah setelah beberapa hari, organ hati mengalami pematangan dan proses pembuangan bilirubin bisa berlangsung lancar, Masa "matang" organ hati pada setiap hati berbeda-beda, Namun umumnya pada hari ketujuh organ hati mulai melakukan fungsinya dengan baik (Marmi,Rahardjo. 2020).

Adapun tanda-tanda ikterus Fisiologi diantaranya Gejala kuning muncul pada 24 jam pertama, kenaikan kadar bilirubin <5 mg/dl, bayi tidak mau menyusu/tidur terus menerus ikterus timbul dalam 24 jam pertama kehidupan, serum bilirubin total lebih dari 12 mg/dl, peningkatan bilirubin 5 mg/dl atau lebih dari 24 jam, kosentrasi bilirubin serum melebihi 10 mg/dl pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan, ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibilitas darah, defisiensi enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD) dan sepsis, ikterus yang disebabkan oleh bayi kurang dari 2000 gram yang disebabkan karena usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun dan kehamilan pada remaja, masa gestasi kurang dari 36 minggu, asfiksia, hipoksia, syndrome gangguan pernapasan, infeksi, hipoglikemia, dan hiperosmolaritas darah sepsis (Maulida,2020:40)

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor, Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut

a) Produksi yang berlebihan lebih dari pada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya misalnya hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6PD, pyruvate kinase, perdarahan tertutup dan sepsis.
b) Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi biliribun, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau

tidak terdapatnya enzim glukorinil transferasi (cringgler najjar syndrome). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperanan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar.

c) Gangguan dalam transfortasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut kehepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya salsilitas, sulfatfurazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang kemudian melekat ke sel otak.

d) Gangguan dalam sekresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.

e) Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat meningkatkan hiperbilirubinemia unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterahepatik.

f) Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat asi merupakan unconjugated hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Dapat dibedakan dari penyakit lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini unruk membedakan pada bayi disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagai bahan yang terkandung dalam Air Susu Ibu (ASI) adalah (beta glucoronidase) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapatkan ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian (Marmi dan Rahardjo, 2020:278-280).

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah :

a) Air Susu Ibu (ASI) yang kurang

Bagi yang mendapat ASI yang cukup saat menyusui dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi prematur yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

b) Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh, bayi yang memiliki jenis golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit atau mendapat transfusi darah, kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

c) Infeksi/ inkompabilitas ABO-Rh

Bermacam infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin didalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Maulida, 2020: 39).

Ikterus disebut normal (fisiologis) jika muncul setelah 24–72 jam dan menghilang sebelum usia 2 minggu. Pada kondisi ini, bilirubin yang belum terkonjugasi (*Unconjugated bilirubin*) terdeteksi kurang dari 15 mg/dl, namun menurut AAP masih dianggap normal jika di bawah 17–18 mg/dl. Berbagai faktor resiko yang merupakan penyebab dari ikterus fisiologis bisa dari faktor ibu maupun faktor bayi. Yang sering

ditemukan antara lain dari faktor maternal seperti komplikasi kehamilan (*inkomptabilitas golongan darah ABO dan Rh*) dan pemberian air susu ibu (ASI). Faktor perinatal seperti infeksi, dan trauma lahir (*cephalhermaton*) dan faktor neonatus seperti prematuritas, rendahnya asupan ASI, hipoglikemia, dan faktor genetik (Faiqah, Syajaratuddur, 2020: 1355-1357)

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “F” dengan ikterus patologis melalui anamnesa, didapatkan ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 26 agutus 2025, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 25 agustus 2025, ibu pasien mengatakan bayinya lahir cukup bulan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi cukup baik, kulit dan sklera bayi terlihat kuning refleks menghisap dan menelan lemah.

Menurut penelitian Faiqah, Syajaratuddur, 2020 Ikterus disebut normal (fisiologis) jika muncul setelah 24–72 jam dan menghilang sebelum usia 2 minggu dengan faktor resiko yang merupakan penyebab dari ikterus fisiologis bisa dari faktor ibu maupun faktor bayi yang dimana pada ibu pemberian air susu ibu (ASI) dan pada bayi yaitu rendahnya asupan air susu ibu (ASI).

Pada kasus By Ny “F” data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan.

2. Identifikasi Diagnosa Atau Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Ikterus fisiologis timbul pada hari kedua dan hari ketiga yang tidak mempunyai dasar patologis, kadarnya tidak melewati kadar yang membahayakan atau mempunyai potensi menjadi kern ikterus dan tidak menyebabkan satu morbiditas pada bayi. ikterus ini biasanya menghilang pada minggu pertama atau selambat-lambatnya 10 hari pertama (Prawirohardjo, 2020).

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut :

a) Produksi yang berlebihan lebih dari pada kemampuan bayi untuk mengeluarkannya misalnya hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6PD, pyruvate kinase, perdarahan tertutup dan sepsis.
b) Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi biliribun, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukorinil transferasi (*cringgler najjar syndrome*). Penyebab lain ialah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperanan penting dalam uptake bilirubin ke sel-sel hepar.
c) Gangguan dalam transfortasi bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut kehepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya salsilitas, sulfatfurazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang kemudian melekat ke sel otak.
d) Gangguan dalam sekresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.
e) Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat meningkatkan hiperbilirubinemia unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterahepatik.
f) Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat asi merupakan unconjugated hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Dapat dibedakan dari penyakit lain dengan reduksi kadar bilirubin yang cepat bila disubstitusi dengan susu formula selama 1-2 hari. Hal ini unruk membedakan pada bayi disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagai bahan yang terkandung dalam Air Susu Ibu (ASI) adalah (beta glucoronidase) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan

meningkat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapatkan ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan asupan beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberian (Marmi dan Rahardjo, 2020: 278-280).

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah :

(1) Air Susu Ibu (ASI) yang kurang Bagi yang mendapat ASI yang cukup saat menyusui dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi prematur yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

(2) Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh, bayi yang memiliki jenis golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit atau mendapat transfusi darah, kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

(3) Infeksi/ inkompabilitas ABO-Rh Bermacam infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin didalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Maulida, 2022)

Menurut Maryunani 2020, Tanda dan gejala neonatus dengan ikterus adalah kulit dan sklera mata kuning, terjadi pembesaran hati, tidak mau minum ASI, letargi, refleks isap dan menelan bayi lemah (Maryunani, 2020: 104).

Dari tinjauan kasus diperoleh data: Bayi Ny "F" mengalami ikterus pada 1 hari setelah lahir yang dimana bayinya lahir pada tanggal 25 agustus 2025 dan mengalami ikterus pada 26 agustus 2025 dengan mengalami perubahan warna kulit yang terlihat pada kulit dan sklera mata bayi yang berwarna kuning, bayi juga tidak menyusui dengan baik pada tanggal 25 agustus 2026, serta reflek isap dan menelan bayi yang lemah.

Menurut penelitian terdahulu dari (Bijanti Retno,2022). Bahwa Ikterus Fisiologis merupakan Kondisi ikterus yang umum, ringan, normal dan hanya bersifat sementara pada bayi baru lahir yang muncul setelah 24 jam dan hilang <14 hari (Kurang dari 14 hari) yang dimana yang menjadi faktor terjadinya ikterus fisiologi itu sendiri diantaranya hipoksia, kurangnya asupan ASI, penyakit membrane hialin (HMD), hipoglikemia, asidosis, hipotermia dan hipoprotemia dan kematangan organ hati bayi yang belum sempurna untuk memproses dan mengeluarkan bilirubin (Bijanti Retno,2022).

Maka Pada kasus By Ny "F" menunjukkan adanya persamaan antara teori tinjauan dengan diagnosa sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan.

3. Identifikasi Diagnosis/ Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila masalah potensial terjadi. Apabila ikterus fisiologi tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya semakin tinggi maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena bilirubin dapat menumpuk diotak yang disebut dengan kern ikterus (Herawati dan Maya, 2020: 68). Hiperbilirubin fisiologis merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang

menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2020: 17).

Kondisi hiperbilirubinemia fisiologis yang tak terkontrol dan kurang penanganan yang baik dapat dapat menimbulkan komplikasi yang berat seperti kern ikterus akibat efek toksik bilirubin pada sistem saraf pusat (Mastiningsih, Putu, 2020:15).

Salah satu penyebab mortalitas pada bayi baru lahir adalah kern ikterus yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat yang dapat menimbulkan gejala sisa berupa cerebral palsy, tuli nada tinggi, paralisis dan displasia dental yang sangat mempengaruhi kualitas hidup (Maulida, Luluk Fajria, 2021: 39)

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya kern ikterus yaitu dengan adanya pengawasan antenatal yang baik serta pertolongan persalinan yang aman dengan berpedoman pada asuhan sayang ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian ikterus neonatorum, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik maka 75% bayi hiperbilirubinemia fisiologis akan meninggal dan dampak yang terjadi apabila bayi mengalami hiperbilirubinemia 80% dari bayi yang hidup akan mengalami keterbelakangan mental (Maulike, Novie dan Nurjanah Ade, 2020: 17).

Pada kasus bayi Ny “F” telah dilakukan penanganan umum dan penanganan segera dengan melakukan pemberian foto terapi selama 2x24 jam, dan pemberian susu formula setiap 3 jam sekali sebagai penganti ASI sehingga masalah potensial (kern ikteus) tidak muncul. Hal ini dikarenakan penanganan yang tepat dan baik, Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Pada kasus bayi “F” telah dilakukan observasi penanganan umum dan penanganan segera dengan pemberian foto terapi dan pemenuhan nutrisi cairan dalam pemberian susu formula sebagai penganti ASI sehingga masalah potensial (kern ikteus) tidak muncul. Hal ini dikarenakan penanganan yang tepat dan baik, Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Menurut (Purwoastuti, 2020).Tujuan utama fototerapi pada bayi dan pemberian ASI adalah untuk mengatasi penyakit kuning (ikterus neonatorum) dengan cara memecah kadar bilirubin dalam darah sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh bayi melalui urine dan feses.

Pada kasus By Ny "F" data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan.

4. Mengidentifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan bayi, dimana situasi yang memerlukan tindakan segera oleh bidan dengan dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut dalam pemberian foto terapi pada setiap bayi yang mengalami ikterus neonatorum (Mufdillah, dkk, 2020)

Pada kasus bayi Ny "F" dengan ikterus fisiologis dilakukan kolaborasi antara bidan dengan dokter dalam melakukan pemberian foto terapi dan pemberian susu formula sebagai penganti asi setiap 3 jam sekali. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata dilapangan.

Menurut penelitian terdahulu (Purwoastuti, 2020), Untuk bayi baru lahir (BBL) dengan ikterus fisiologis, tindakan segera yang diberikan adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif dan memastikan bayi cukup nutrisi, melakukan kolaborasi dengan dokter yang diperlukan untuk melakukan pemberian fototerapi, yang menggunakan sinar untuk membantu tubuh memecah bilirubin.

Pada kasus By Ny "F" data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan.

5. Intervensi / Perencanaan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya.

Langkah ini merupakan kelanjutan manjemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi dan pada langkah ini reformasi data yang

tidak lengkap bisa dilengkapi. Perencanaan ini disusun berdasarkan diagnosa, masalah dan kebutuhan. Pada kasus bayi dengan ikterus fisiologi rencana asuhan yang dilakukan adalah observasi KU umum yang bertujuan untuk memantau agar keadaan bayi tidak mencapai nilai yang menimbulkan kern ikterik, penuhi kebutuhan nutrisi secara baik karena bayi malas minum serta mencegah bayi tidak dehidrasi karena pengaruh sinar lampu, kolaborasi dengan dokter spesialis anak, observasi BAB dan BAK, juga lingkungan sekitar bayi dijaga agar tetap bersih dan hangat (Mufdillah, dkk, 2022). Perencanaan asuhan yang dilakukan pada bayi dengan ikterus fisiologis adalah fototerapi dan pemenuhan nutrisi cairan yang dimana dapat menurunkan bilirubin yang ada pada bayi

Pada kasus bayi "F" dengan ikterus fisiologi perencanaan yang dilakukan antara lain: cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan kolaborasi dengan dalam melakukan tindakan, memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "F" tentang kondisi bayi "F" saat ini.

Menurut Mathindas, dkk, 20120: S8) Perencanaan asuhan pada bayi baru lahir (BBL) dengan ikterus fisiologis meliputi pemantauan kadar bilirubin, fototerapi, stimulasi pemberian ASI eksklusif, edukasi kepada orang tua dengan tujuan dari perawatan itu sendiri adalah untuk menurunkan kadar bilirubin, mencegah peningkatan lebih lanjut, dan memastikan bayi mendapat nutrisi yang cukup.

Sehingga pada tahap ini, pada kasus By Ny "F" data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan antara teori dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan.

6. Implementasi/Pelaksanaan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan

oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota kesehatan yang lain. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi dia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaanya sehingga dapat meningkatkan mutu dan asuhan pada bayi dengan ikterus fisiologi. Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari keluarga pasien dan dukungan dari petugas kesehatan.

Menurut (Maulida, Fajria Luluk, 2020 : 41-43), Pentalaksanaan yang dilakukan pada bayi dengan ikterus fisiologi adalah Pemberian ASI secara optimal perlu diingat bahwa bilirubin dapat dipecah apabila bayi mengeluarkan feses dan urin. Sehingga pemberian ASI harus diberikan sebab ASI sangat efektif dalam memperlancar BAB dan BAK. Namun demikian, pemberiannya harus tetap dalam pengawasan dokter.

Pada kasus bayi “F” dengan ikterus fisiologi, penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menjaga kehangatan bayi, Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 27 agustus 2025 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi,menjaga kehangatan bayi, Penatalaksanaan tanggal 28 agustus 2025 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi, bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberi tahu keluarga bayi bahwa bayi sudah dianjurkan untuk pulang, dan memberikan KIE pada orang tua bayi

Pada kasus By Ny “F” data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan gejala yang terdapat dalam teori dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan.

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai dengan masalah dan diagnosis klien, juga benar dalam pelaksanaanya. Disamping melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah diberikan, bidan juga dapat melakukan evaluasi terhadap proses asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan, hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. Pada teori bayi dengan hiperbilirubinemia keadaan yang ingin dicapai adalah KU bayi baik, kenaikan berat badan bayi, warna kuning pada kulit bayi sudah tidak terlihat, kebutuhan cairan bayi terpenuhi, reflex isap baik (Mufdillah, dkk, 2020: 111-119).

Berdasarkan implementasi yang diberikan pada bayi Ny “F” dari asuhan pertama sampai asuhan terakhir, telah sesuai dan berjalan dengan baik diantaranya cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan kolaborasi dengan dalam melakukan tindakan, memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi “F” tentang kondisi bayi “F”, serta ibu bersedia melakukan kunjungan ulang kembali jika terdapat keluhan.

Sehingga Pada kasus By Ny “F” data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan yang terdapat dalam teori dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan.tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata dilapangan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis dapatkan dalam studi kasus dan pembahasan pada asuhan kebidanan pada bayi Ny "F" dengan ikterus Fisiologi di RS TK II Prof dr J.A Latumeten Ambon, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk peningkatan pelayanan asuhan kebidanan khususnya pada bayi dengan Ikterus Fisiologis.

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada bayi Ny "F" dengan ikterus Fisiologi dilaksanakan dengan mengumpulkan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara dimana ibu pasien mengatakan kulit dan sclera mata bayinya berwarna kuning, sedangkan untuk data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti kulit dan sklera bayi nampak kuning, refleks isap dan menelan bayi lemah.
2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada bayi Ny "F", yaitu dengan ikterus fisiologi yang disertai dengan masalah kekurangan kebutuhan nutrisi.
3. Diagnosa potensial pada kasus ini adalah bayi akan mengalami *Kern Ikterus* (Kerusakan Otak)
4. Perlunya tindakan segera atau kolaborasi dalam langkah ini dilakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian Foto Terapi yang bertujuan untuk menurunkan kadar bilirubin dan pemberian susu formula sebagai penganti ASI per 3 jam sebanyak 3 cc
5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh, pada kasus ini rencana asuhan yang dilakukan Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi

Observasi Keadaan Umum bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, Jaga kehangatan bayi, Berikan susu formula sebagai penganti ASI, Menganti pakaian dan popok bayi ketika basah/lembab, Lakukan foto terapi pada bayi.

6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada bayi Ny "F" merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan diantaranya mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada bayi, Melakukan observasi Keadaan Umum bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, Menjaga kehangatan bayi, Berikan susu formula sebagai penganti ASI, Menganti pakaian dan popok bayi ketika basah/lembab, Lakukan foto terapi pada bayi
7. Evaluasi, setalah dilakukan asuhan kebidanan selama 3 hari pada kasus bayi Ny "F" dengan ikterus fisiologi didapat hasil KU bayi baik, reflex menghisap dan menelan kuat, sklera dan kulit bayi sudah tidak kuning, kebutuhan nutrisi tercukupi.

B. Saran

1. Untuk Rumah Sakit

   Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan pada bayi agar dapat mempercepat proses penyembuhan khususnya pada bayi dengan ikterus fisiologi dan mencegah terjadinya komplikasi
2. Bagi Bidan

   Dapat meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi bayi dengan ikterus neonatorum fisiologi secara cepat, tepat dan komprehensif
3. Bagi Institusi pendidikan

   Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi terkait dengan masalah ikterus neonatorum, sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang akan mengambil kasus yang sama dalam memperoleh informasi

DAFTAR PUSTAKA

Anggaraini Yetti. *Hubungan antara Persalinan Premature dengan Hiperbilirubin*

Ardhiyanti, Y. (2021). „asuhan kebidanan pada bayi ny.n dengan ikterus fisiologis‟, *Bilirubinemia pada Bayi Ikterus* di RSUP NTB: Jurnal Kesehatan Prima, Vol 8, No.2.Agustus 2021.

Bijanti Retno,2022 „asuhan kebidanan pada bayi ny.n dengan ikterus fisiologis‟, komunikasi kesehatan vol.x no 2tahun 2022.

Faiqah, Syajaratuddur. *Hubungan Usia Gestasi dan Jenis Persalinan Dengan Kadar Hiperbilirubinemia dengan Sikap dan Perilaku Menjemur Bayi*. Surakarta: JIK. Vol. 4. 2. 2022.

Indrayani dan Moudy Emma Unaria Djami. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta*: CV Trans Info Media. 2022.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022

Kementrian Republik Indonesia. Survey *Demografi Kesehatan Indonesia* (SDKI).2022.Jakarta: badan penelitian dan perkembangan kementrian RI.

Maulida, Luluk Fajria. *Ikterus Neonatorum*: PROFESI. Vol.10, No.3. September, 2013-Februari 2020.

Maulike, Novie dan Nurjannah Ade. *Faktor-Faktor Pada Ibu Bersalin Yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi Baru Lahir.Jurnal Kesehatan Kartika.*Vol.8 No.4 Maret 2021.

pada Neonatus. Lampung: *Jurnal Kesehatan*, Volume V, Nomor 2, Oktober 2014, hlm109 112.2022.

Oktaria Mika,(2021). kelainan penyakit pada bayi dan anak. Yogyakarta: Oktaria Mika

Fatma et al.,(2021)asuhan neonatus bayi dan balita. Binarupa Aksara.

Ilawati, S. and Susanti, N. (2022). „Hubungan pengetahuan dan sikap ibu terhadap pencegahn ikterus fisiologis pada bayi usia 0-14 Hari dusun 1,sei mencirim village‟, of healthcare technology and medicine

RN Lochart Anita, dan Lyndon Saputra. *Asuhan Kebidanan Neonatus Normal dan Patologi. Tangerang Selatan: Pustaka Pelajar. 2020.*

Setyaningsih Rahayu, Ersa Trianingsih. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang komunikasi kesehatan vol.x no 2tahun 2020 .

Krishnan Elango, dkk.2016. Evaluation Of Cord Bilirubin and Hemoglobin Analysis in

Predicting Pathological Jaundice in Term Babies at Introduction Risk of ABO Incompatibility. International Journal of Research in Medical Sciences. 2020. Vol 4.Issue 10. Page 4545.

Susanti et al.,(2022). Ilmu kebidanan.jakarta: P.T Bina pustaka

Maulida, Luluk Fajria. Ikterus Neonatorum: PROFESI. Vol.10, No.3. September 2020-Februari 2021.

Maulike,Novie dan Nurjannah Ade.Faktor-Faktor Pada Ibu Bersalin Yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi Baru Lahir. Jurnal Kesehatan Kartika.Vol.8 No.4 Maret 2020.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembaran Konsultasi judul

Lampiran 2. Surat Pengambilan Data Awal

YAYASAN BANGUN PERSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON
Jl. Suli Raya, Telp. (0911) 353317: Email: pasapuaambon@gmail.com
Izin: Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 172/D/O/2009
Rekomendasi Depkes R.I Nomor : HK/05/I/II/4/4611/2009

Nomor : 287/STIKES/PA/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan Pengambilan Data Awal Penelitian***

Kepada Yth :
Direktur RS TK II Prof. dr. J. A Latumeten Ambon
Di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses penyusunan KTI yang merupakan persyaratan lulus bagi mahasiswa semester VI Prodi DIII Kebidanan STIKES Pasapua Ambon TA.2024/2025, maka kami mohon kesediaan Bapak /Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan Pengambilan Data Awal pada instansi yang dipimpin oleh Bapak/Ibu:

Nama : Hesty Sintia Septory
NIM : B2214016
Judul Proposal : Manajemen Asuhan Kebidanan Neonatus Dengan Ikterus Di Rumah Sakit TK II Prof. dr. J. A Latumeten Ambon

Rencana Pelaksanaan : Rabu, 20 Agustus 2025 - Selesai
Demikian penyampaian kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Suli, 20 Agustus 2025
Mengetahui ,
Wakil Ketua I Bidang Akademik

Melawati Wakano, S.S.T.,M.Keb
NIDN . 1222069101

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Yayasan Bangun Persada Ambon
2. Ketua STIKES Pasapua Ambon
3. Arsip

Lampiran 1. Surat Disposisi Pengambilan Data Awal

KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA
RUMAH SAKIT Tk.II Prof. dr. J.A. LATUMETEN

LEMBAR DISPOSISI
Nomor : Agenda/ 297 / VIII /2025

Terima dari	: STIKES PAMAPUA Ambon		
Tanggal Terima	: 21 /8 /25	Pukul	: 400
Nomor Surat	: 297 / STIKES /PA / VIII /2025	Tanggal	: 20 /8 /25

Yth. **Kepala Rumah Sakit Tk.IIProf.dr. J.A. Latumeten**
Perihal : Permohonan Pengambilan Data Awal Penelitian

DISPOSISI Waka :	DISPOSISIKABID UM & KU / KASI :
Yth. Karumkit Mohon ijin surat tg Pemohon pengambilan data awal penelitian	YTH Waka, Permohonan pengambilan data awal penelitian.

DITERUSKAN KEPADA :

1.	**Dewan Pengawas :** Pangdam / Kakes	17.	PakuRumkit / PPSPM / Bendahara
2.	WaKa	18.	Bendahara Gaji / JuYar
3.	Ketua Komite Medik	19.	Ka UrPers
4.	Ketua Komkordik	20.	Ka UrDal
5.	Ka SPI	21.	Ka UrSIMAK BMN
6.	Kabid Umum & Keuangan	22.	KaPrimkop Kartika Rumkit
7.	Kabid YanMed & Keperawatan	23.	Pa UrPam
8.	Kabid Dik & Litbangkes	24.	**KaDep :** Bedah & Anest / Obsgyn & IKA / Mata, THT & KulKel / Interna, Jtg & Paru / GiLut / Syaraf & Jiwa
9.	**Kasi:** TUUD / JangUm / JangMed / YanMed / RenProgGan / DikLat / LitBangKes / InfoKes	25.	**KaInstal :** WatLan / WatNap / KaBed / Farmasi / RehabMed / JangDiag / Jangwat / GaDar
10.	KaBina Adm BPJS	26.	KetuaTim Akreditasi
11.	Manajer Pelayanan Pasien	27.	**Ketua Komite :**Keperawatan / Keteknisian Medis / PPI / PMKP / PPRA / HTA / Etik & Hukum / K3 & Manajemen Resiko / Etik Lit Kes
12.	Ka ULP		
13.	Ka Unit RikKes / PPBPAD		
14.	Ka Unit PKRS		
15.	Ka Unit CSSD	28.	Ketua Persit Anak Ranting 2
16.	Ka Unit SIMRS	29.	...

1.	Tindak lanjuti	8.	Pelajaridan Laporkan HalJol
2.	Ajukan Saran & Pertimbangan	9.	Buat Laporan Lanjutan
3.	Sebagai Referensi	10.	Monitor / Pantau Selanjutnya
4.	Pedomani	11.	Arsipkan
5.	UDL	12.	KaRumkit Hadir
6.	UDK	13.	Agar diwakili Oleh :
7.	Edarkan	14.	...

DISPOSISI KARUMKIT : 21/8 22

Lampiran 4. Surat Permohonan Penilitan

YAYASAN BANGUN PERSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PASAPUA AMBON
Jl. Suli Raya, Telp. (0911) 353317; Email: pasapuaambon@gmail.com
Izin: Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 172/D/O/2009
Rekomendasi Depkes R.I Nomor : HK/05/I/II/4/4611/2009

Nomor : 307/STIKES/PA/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan Penelitian***

Kepada Yth :
Pimpinan Rumkit Tk II. Prof. dr. J.A. Latumeten
Di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakan proses penyusunan KTI yang merupakan persyaratan lulus bagi mahasiswa semester VI Prodi DIII Kebidanan STIKES Pasapua Ambon TA.2024/2025, maka kami mohon kesediaan Bapak /Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan Penelitian pada instansi yang dipimpin oleh Bapak/Ibu

Nama : Hesty Sintia Septory
NIM : B2214016
Judul Proposal : Manajemen Asuhan Kebidanan Neonatus Ikterus di Rumkit Tk II. Prof. dr. J.A. Latumeten
Rencana Pelaksanaan : Rabu, 27 Agustus 2025 - Selesai

Demikian penyampaian kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Suli, 26 Agustus 2025
Mengetahui ,
Wakil Ketua I Bidang Akademik

Melawati Wakano, S.S.T.,M.Keb
NIDN . 1222069101

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. *Ketua Yayasan Bangun Persada Ambon*
2. *Ketua STIKES Pasapua Ambon*
3. *Arsip*

Lampiran 5. Surat keterangan selesai penilitian

KESEHATAN DAERAH MILITER XV/PATTIMURA
RUMAH SAKIT TINGKAT II Prof. dr. J.A. LATUMETEN

Ambon, **09** September 2025

Nomor : B/ **1158** /IX/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Mahasiswa Penelitian

Kepada
Yth. Wakil Ketua I Bidang
Akademik STIKes
Pasapua Ambon
di
Ambon

1. Dasar :

a. Surat Wakil Ketua I Bidang Akademik STIKes Pasapua Ambon Nomor 307/STIKES/PA/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Permohonan Penelitian di Rumkit Tk II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon; dan

b. Pertimbangan Pimpinan dan Staf Rumkit Tk ii Prof. dr. J.A. Latumeten Kesdam XV/Pattimura.

2. Sehubungan dasar diatas, diberitahukan bahwa Mahasiswa a.n. Hesty Sintia Septory, NIM B2214016, Mahasiswa Program Studi D III Kebidanan STIKes Pasapua Ambon telah selesai melakukan Penelitian dengan Judul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Neonatus Ikterus di Rumkit Tk II. Prof. dr. J.A. Latumeten**" terhitung tanggal 27 Agustus s.d 09 September 2025.

3. Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Kepala Rumah Sakit
Waka
u.b.
Plh. Kepala Instalasi Pendidikan,

KESDAM XV/PATTIMURA
KEPALA
RS Tk II Prof. dr. J.A. Latumeten

Ireine Tauran S.Kep.,Ns., M.Kes
Penda Tk.I- III/b 197407112008122001

Tembusan :

1. Kasituud Rumkit Tk II Prof. dr. J.A. Latumeten
2. Arsip

Lampiran 6. Dokumentasi

Ket: Melakukan Anamnesa	Ket: Melakukan pemberian Susu kepada bayi	Ket: Melakukan observasi pemberian foto terapi pada bayi

Ket: Ruang NICU